NURSING EDUCATIONAL SERIES



HAND HYGIENE

The Cornerstone of Infection Prevention

نظافة الأيدي

حجر الأساس في مكافحة العدوى

> *"Hand hygiene is the single most effective action to reduce healthcare-associated infections."*
>
> **— World Health Organization (WHO)**

RN, Ali Ashour, BSN

أخصائي عناية مركزة (ICU) — 6 سنين خبرة

Bachelor of Science in Nursing

★ BLS CERTIFIED ★

nursehub-egypt.vercel.app

© 2025 NurseHub Egypt — All Rights Reserved

PART 1 OF 5

TABLE OF CONTENTS فهرس المحتويات

PART 1 — FOUNDATIONS الجزء الأول

01	Learning Objectives	03
02	Quick Facts	04
03	Evidence-Based Practice	05
04	Introduction & Definition	06

PART 2 — CORE CONCEPTS الجزء الثاني

05	Importance of Hand Hygiene	07
06	Skin Anatomy & Microflora	08
07	Medical Terminology	09
08	Chain of Infection	10
09	Types of Hand Hygiene ⋆	11
10	Equipment & Supplies	13
11	Indications	14

PART 3 — PROCEDURES الجزء الثالث

12	WHO 5 Moments ⋆⋆⋆	15
13	11-Steps Technique ⋆	17
14	Hand Washing Procedure	18
15	Antiseptic Hand Wash	19
16	Surgical Hand Scrub ⋆	20
17	ABHR Procedure	21
18	Scientific Rationales	22
19	Hand Drying Techniques	23
20	Hand Hygiene with Gloves	24
21	Skin Care & Moisturizers	25
22	Documentation	26
23	Infection Control Standards	27
24	ICU/NICU/OR Considerations	28

PART 4 — CLINICAL SAFETY الجزء الرابع

25	Common Mistakes ⋆	29
26	Red Flags	31
27	Contraindications	32
28	Pediatric Considerations	33
29	Elderly Considerations	34
30	Pregnancy Considerations	35
31	Compliance Monitoring	36
32	Clinical Case Scenarios	37
33	Emergency Situations	38
34	Clinical Pearls	39

PART 5 — EXAM PREP الجزء الخامس

35	Cheat Sheet	40
36	OSCE Checklist ⋆	41
37	OSCE Examiner Tips	42
38	Memory Tricks & Mnemonics	43
39	MCQs (15 Questions)	44
40	True / False (10 Questions)	45
41	Fill in the Blanks	46
42	Interactive Quiz	47
43	AI Flashcards	48
44	AI Revision Notes	49
45	NCLEX/Prometric Tips	50
46	FAQ	51
47	Key Takeaways	52
48	Related Articles	53
49	References (APA 7)	54
50	Back Cover	55

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

01 — Learning Objectives الأهداف التعليمية

What You Will Master by the End of This Guide / ما ستتقنه بنهاية هذا الدليل

By the end of this comprehensive guide, the learner will be able to:

بنهاية هذا الدليل الشامل، سيكون المتعلم قادراً على:

1	**Define** Hand Hygiene and its main types.	**تعريف** نظافة الأيدي وأنواعها الرئيسية.
2	**Explain** the scientific rationale behind hand hygiene.	**شرح** الأساس العلمي لنظافة الأيدي.
3	**Apply** the WHO 5 Moments in clinical practice.	**تطبيق** اللحظات الخمس حسب WHO في الممارسة.
4	**Demonstrate** the 11-step WHO technique (40–60 sec).	**إتقان** خطوات الغسيل الـ 11 (40–60 ثانية).
5	**Perform** ABHR procedure correctly (20–30 sec).	**أداء** تعقيم الأيدي بالكحول (20–30 ثانية).
6	**Identify** the 10 most common mistakes in hand hygiene.	**تحديد** أشهر 10 أخطاء أثناء غسل الأيدي.
7	**Recognize** when to use each type of hand hygiene.	**معرفة** متى تستخدم كل نوع من الأنواع.
8	**Apply** hand hygiene in special populations (Peds, Elderly, ICU).	**تطبيق** نظافة الأيدي مع الفئات الخاصة.
9	**Pass** the Hand Hygiene OSCE station with 100% compliance.	**اجتياز** محطة OSCE بنسبة التزام 100%.

Learning Outcome: Master hand hygiene → Prevent HAIs → Save lives.

المخرج التعليمي: إتقان نظافة الأيدي ← منع العدوى ← إنقاذ الأرواح.

Study Tip: Read each section twice — first for understanding, second for memorization.

نصيحة: اقرأ كل قسم مرتين — الأولى للفهم والثانية للحفظ.

Source: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009) ▪ CDC Hand Hygiene Guidelines (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

02 — Quick Facts حقائق سريعة

Key WHO & CDC Statistics / أهم الإحصائيات العالمية

50% **Reduction in HAIs** انخفاض في عدوى المستشفيات	**40-60s** **Hand Washing Time** مدة الغسيل	**20-30s** **ABHR Duration** مدة الكحول
5 **WHO Moments** اللحظات الخمس	**11** **Technique Steps** خطوات الغسيل	**60-95%** **Alcohol Concentration** تركيز الكحول

 Global Impact: 1.4 million patients worldwide suffer from HAIs at any given time. Every year, 7 out of every 100 hospitalized patients acquire at least one HAI in developed countries — and 15 out of every 100 in developing countries.

 التأثير العالمي: 1.4 مليون مريض حول العالم يعانون من عدوى المستشفيات في أي وقت. كل سنة، 7 من كل 100 مريض في الدول المتقدمة يصابون بعدوى واحدة على الأقل — والنسبة ترتفع لـ 15 من كل 100 في الدول النامية.

Hand Hygiene compliance in most hospitals: **< 40%**	نسبة الالتزام بنظافة الأيدي: **أقل من 40%**
1 gram of feces can contain **1 trillion** microbes.	جرام واحد من البراز يحتوي على **تريليون ميكروب**.
Healthcare workers touch **5 patients/shift** on average.	الفريق الطبي يلمس **5 مرضى/مناوبة** في المتوسط.
⚠ **Critical Fact:** Improved hand hygiene compliance can reduce HAIs by up to **50%** and save thousands of lives annually.	⚠ **حقيقة صادمة:** تحسين الالتزام بنظافة الأيدي يقلل العدوى لحد **50%** ويُنقذ آلاف الأرواح سنوياً.

Source: WHO Save Lives: Clean Your Hands Campaign (2023) ▪ CDC HAI Progress Report (2022).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Latest Research & International Guidelines / أحدث الأبحاث والمعايير العالمية

WHO 2009 **Guidelines on Hand Hygiene in Health Care**

Established the **"5 Moments for Hand Hygiene"** framework, adopted globally as the gold standard. Recommends ABHR as the first-line option except when hands are visibly soiled.

وضعت إطار **"اللحظات الخمس لنظافة الأيدي"** اللي بقى المعيار الذهبي عالمياً، وأوصت بالكحول كخيار أول ما لم تكن الأيدي متسخة بشكل واضح.

Ref: World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva: WHO Press; 2009.

CDC 2023 **Hand Hygiene in Healthcare Settings**

Confirmed that **alcohol-based hand rubs** are more effective than soap and water for routine decontamination and cause less skin irritation.

أكد إن **الكحول** أكثر فعالية من الماء والصابون في التطهير الروتيني وأقل تهييجاً للجلد.

Ref: Centers for Disease Control and Prevention. Hand Hygiene Guidelines. Atlanta: CDC; 2023.

Pittet 2000 **Landmark Geneva Hospital Study**

Improved hand hygiene compliance from **48% to 66%** reduced overall HAI prevalence by **41%** and MRSA transmission by **50%**.

رفع نسبة الالتزام من **48%** لـ **66%** أدى لتقليل العدوى بنسبة **41%** وتقليل انتقال MRSA بنسبة **50%**.

Ref: Pittet D, et al. The Lancet. 2000;356(9238):1307-1312.

Evidence Level: Hand Hygiene guidelines are supported by **Level 1A evidence** — the highest quality of clinical evidence available.

مستوى الدليل: توصيات نظافة الأيدي مدعومة بـ**دليل من المستوى 1A** — أعلى مستوى من الأدلة السريرية.

Sources: WHO (2009) ▪ CDC (2023) ▪ Pittet D et al. Lancet (2000) ▪ Boyce & Pittet MMWR (2002).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

What Is Hand Hygiene? / ما هي نظافة الأيدي؟

Introduction: Despite its apparent simplicity, **Hand Hygiene** is the **cornerstone** of any Infection Prevention and Control (IPC) program. The hands of healthcare workers are the most dangerous vehicle for microbial transmission inside hospitals — they represent the direct connection between the patient, the equipment, the environment, and the medical team.

المقدمة: رغم بساطة الإجراء، إلا إن **نظافة الأيدي** هي **حجر الأساس (Cornerstone)** في أي برنامج لمكافحة العدوى (IPC). الإيدين بتُعتبر أخطر وسيلة لنقل الميكروبات داخل المستشفيات، لأنها حلقة الوصل المباشرة بين المريض، الأدوات، البيئة، والفريق الطبي.

Definition (WHO): Hand Hygiene is a general term referring to any action of hand cleansing aimed at reducing or removing microorganisms — both **transient flora** (temporary) and **resident flora** (permanent skin bacteria) — from the hands.

التعريف (حسب WHO): نظافة الأيدي مصطلح شامل يشير لأي إجراء بيتعمل علشان إزالة أو تقليل الميكروبات — سواء **الميكروبات المؤقتة (Transient flora)** أو **الميكروبات الدائمة على الجلد (Resident flora)** — من على الإيدين.

Hand Hygiene includes 4 types:	نظافة الأيدي تشمل 4 أنواع:
1. **Hand Washing** — with soap & water.	1. **الغسيل الروتيني** — بالماء والصابون.
2. **Antiseptic Hand Wash** — antimicrobial soap.	2. **الغسيل الصحي** — بصابون مطهّر.
3. **Alcohol-Based Hand Rub (ABHR)** — waterless.	3. **التعقيم بالكحول (ABHR)** — بدون ماء.
4. **Surgical Hand Antisepsis** — pre-op.	4. **الغسيل الجراحي** — قبل العمليات.

The Main Goal: To **break the Chain of Infection** and prevent transmission of bacteria, viruses, fungi, and parasites from one source to another.

الهدف الأساسي: هو **كسر سلسلة العدوى (Chain of Infection)** ومنع انتقال البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، والطفيليات من مصدر لآخر.

Golden Rule: Clean hands save lives. It's the simplest, cheapest, and most effective infection control measure ever known.

القاعدة الذهبية: الإيدين النضيفة بتنقذ الأرواح. ده أبسط وأرخص وأقوى إجراء لمكافحة العدوى في التاريخ الطبي.

Source: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009), Chapter 1 ▪ Boyce & Pittet MMWR (2002).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

05 — Importance of Hand Hygiene أهمية نظافة الأيدي

Why Hand Hygiene Is Called "The Cornerstone" / لماذا هي حجر الأساس؟

Why is Hand Hygiene So Important? It's not just a routine procedure — it is the **#1 evidence-based intervention** to reduce healthcare-associated infections worldwide.

ليه نظافة الأيدي مهمة جداً؟ مش مجرد إجراء روتيني — دي **أول وأهم إجراء** مبني على الدليل العلمي لتقليل عدوى المستشفيات حول العالم.

1. Reduces HAI Transmission: Prevents spread of MRSA, VRE, C. difficile, and other multi-drug resistant organisms.	**1. تقليل انتشار عدوى المستشفيات:** بتمنع انتقال البكتيريا المقاومة زي MRSA و VRE و C. difficile.
2. Protects the Medical Team: Reduces occupational exposure to HBV, HCV, HIV, and other infectious diseases.	**2. حماية الفريق الطبي:** بتقلل التعرض المهني لفيروسات الكبد HBV و HCV، وفيروس HIV.
3. Reduces Antibiotic Resistance: Preventing HAIs = less antibiotic use = less resistance.	**3. تقليل مقاومة المضادات الحيوية:** منع العدوى = استخدام أقل للمضادات = مقاومة أقل.
4. Cost-Effective: A single HAI costs $10,000–$50,000. Hand hygiene costs pennies — highest ROI in healthcare.	**4. أرخص إجراء بأعلى فعالية:** علاج عدوى واحدة يكلف 10-50 ألف دولار. نظافة الأيدي بتكلف قروش قليلة.
5. Reduces Hospital Stay: Prevents complications that extend hospitalization by 7–10 days per HAI.	**5. تقليل مدة الإقامة:** بتمنع مضاعفات بتطوّل الإقامة 7-10 أيام لكل حالة عدوى.
In Simple Words: Clean hands save lives. Period.	**ببساطة:** الإيدين النضيفة بتنقذ الأرواح. خلاص.

Source: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009), Chapter 2 • CDC HAI Data Portal (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Hand Skin Structure & Its Microbial Inhabitants / تركيب جلد اليد والميكروبات عليه

Understanding Hand Microflora: The human skin hosts two distinct types of microorganisms. Knowing the difference determines which type of hand hygiene to use.

فهم الميكروبات على الأيدي: جلد الإنسان يحتوي على نوعين مختلفين من الميكروبات. معرفة الفرق يحدد نوع نظافة الأيدي المناسب.

Feature الخاصية	Transient Flora	Resident Flora
Location المكان	Superficial skin layers طبقات الجلد السطحية	Deeper layers & follicles طبقات عميقة والبصيلات
Origin المصدر	Picked up from patients من المرضى والأسطح	Naturally on skin موجودة طبيعياً
Examples أمثلة	S. aureus, E. coli, MRSA S. aureus, E. coli, MRSA	Staph. epidermidis Staph. epidermidis
Pathogenic ممرضة؟	Yes — disease-causing أيوه — بتسبب أمراض	Usually harmless غير ضارة عادة
Removal الإزالة	Easily by washing/ABHR تُزال بسهولة	Requires surgical scrub تحتاج غسيل جراحي
Duration مدة البقاء	Minutes to hours دقائق لساعات	Permanent دائمة

⚠ **Critical:** Transient flora is the **main cause of cross-infection**. Hand hygiene targets these microbes primarily.

⚠ **نقطة حرجة:** الميكروبات المؤقتة هي **السبب الرئيسي لانتقال العدوى**. نظافة الأيدي بتستهدفها بشكل أساسي.

Clinical Pearl: Standard washing removes 99% of transient flora in 40–60 sec. Surgical scrub reduces resident flora before operations.

لؤلؤة سريرية: الغسيل العادي يزيل 99% من الميكروبات المؤقتة في 40-60 ثانية.

Fun Fact: Hand skin contains **150 million bacteria per cm²**. Most concentrated: under nails & finger creases.

معلومة: جلد الأيدي فيه **150 مليون بكتيريا في السنتيمتر²**. أكتر الأماكن: تحت الأظافر.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 4 ▪ Boyce & Pittet MMWR (2002).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Aa Essential Terms Every Nurse Must Know / مصطلحات لازم كل ممرض يعرفها

Hand Hygiene (HH) — General term for any hand cleansing action.	**نظافة الأيدي** — مصطلح شامل لأي إجراء لتنظيف الإيدين.
Hand Washing — Washing with plain soap and water.	**الغسيل الروتيني** — بالصابون العادي والماء.
Antiseptic Hand Wash — Washing with antimicrobial soap.	**الغسيل الصحي** — بالصابون المُطهّر.
ABHR — Alcohol-Based Hand Rub (waterless).	**ABHR** — التعقيم بالكحول (بدون ماء).
Surgical Scrub — Pre-op antiseptic hand wash.	**الغسيل الجراحي** — قبل العمليات.
HAIs — Healthcare-Associated Infections.	**HAIs** — عدوى المستشفيات.
IPC — Infection Prevention and Control.	**IPC** — مكافحة العدوى.
Transient Flora — Temporary skin microbes.	**الميكروبات المؤقتة** — على سطح الجلد.
Resident Flora — Permanent skin microbes.	**الميكروبات الدائمة** — في الطبقات العميقة.
Cross-Infection — Transmission patient to patient.	**العدوى المتقاطعة** — انتقال من مريض لآخر.
Chain of Infection — 6 links needed to spread.	**سلسلة العدوى** — 6 حلقات لانتشار العدوى.
MRSA — Methicillin-Resistant Staph. aureus.	**MRSA** — بكتيريا مقاومة الميثيسيلين.
C. difficile — Spore-forming; needs soap & water.	**C. difficile** — بكتيريا مُبوَّغة؛ تحتاج ماء وصابون.
5 Moments — WHO framework for when to do HH.	**اللحظات الخمس** — إطار WHO لتوقيت النظافة.
SSI — Surgical Site Infection.	**SSI** — عدوى موضع الجراحة.
Compliance — Rate of following HH standards.	**الالتزام** — نسبة تطبيق معايير النظافة.

 Study Tip: Master these abbreviations — they appear in every nursing exam.

 نصيحة: احفظ الاختصارات دي كويس — بتظهر في كل امتحان تمريض.

Source: WHO Glossary (2009) ▪ CDC Terminology Guide (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

How Hand Hygiene Breaks the Chain / كيف تكسر نظافة الأيدي السلسلة؟

The 6 Links of Infection: For any infection to spread, all 6 links must be present. Breaking ANY link stops the infection. Hand hygiene breaks the most common link: **Mode of Transmission (Link #4)**.

الحلقات الست لسلسلة العدوى: لتنتشر أي عدوى، لازم 6 حلقات كلها موجودة. كسر أي حلقة يوقف العدوى. نظافة الأيدي تكسر أشهر حلقة: **طريقة الانتقال (حلقة 4)**.

1 Infectious Agent المُسبِّب	2 Reservoir المستودع	3 Portal of Exit منفذ الخروج
4 Mode of Transmission ⚠ طريقة الانتقال (الأيدي!)	5 Portal of Entry منفذ الدخول	6 Susceptible Host المُضيف المُعرَّض

⚠ The Weakest Link: The **hands of healthcare workers** are the main vehicle of transmission (Link #4). Hand hygiene intervenes here to stop the entire chain.

⚠ الحلقة الأضعف: إيدين الفريق الطبي هي الوسيلة الأساسية للنقل (حلقة 4). نظافة الأيدي بتتدخل هنا لتوقف السلسلة كلها.

The Power: By breaking Link #4, you prevent microbes from reaching a new host — even if all 5 other links exist.

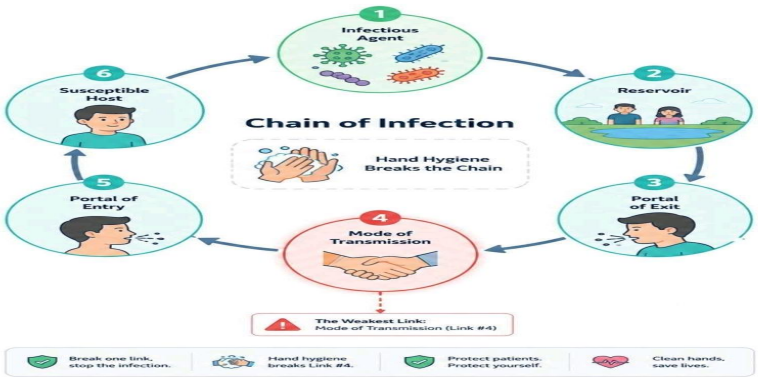
القوة: لما بتكسر الحلقة 4، بتمنع الميكروب من الوصول لمُضيف جديد.

Evidence: Consistent hand hygiene compliance interrupts up to **80% of nosocomial infections**.

الدليل العلمي: الالتزام المستمر بنظافة الأيدي بيمنع لحد **80% من عدوى المستشفيات**.

Key Message: Your hands are a double-edged sword. Clean = save lives. Contaminated = kill patients. Choose!

خلاصة: إيدك سلاح ذو حدين. نضيفة = تنقذ حياة. ملوثة = تقتل مريض. اختار!



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

09 — Types of Hand Hygiene ★ أنواع نظافة الأيدي

The 4 Main Types — Complete Overview / الأنواع الأربعة الرئيسية

 Hand Hygiene Is Not One Type! There are **4 main types** — each with its own indication, duration, and technique.

 نظافة الأيدي مش نوع واحد! فيه **4 أنواع رئيسية** — كل نوع له استخدامه ومدته وتقنيته.

TYPE 1: Social Hand Washing (Routine) النوع 1: الغسيل الروتيني

Definition: Washing with plain soap and water.
Duration: 40–60 seconds
Agent: Plain or medicated soap
Target: Removes dirt + transient flora
When: Start/end of shift, before meals, after toilet.

التعريف: بالماء والصابون العادي.
المدة: 40–60 ثانية
المطهّر: صابون عادي أو طبي
الهدف: إزالة الأوساخ والميكروبات المؤقتة
متى: بداية/نهاية الشيفت، قبل الأكل.

TYPE 2: Antiseptic Hand Wash (Hygienic) النوع 2: الغسيل الصحي

Definition: With antimicrobial soap and water.
Duration: 40–60 sec (Betadine 2–3 min)
Agent: Chlorhexidine 4%, Betadine 7.5%
Target: Transient + partial resident flora
When: ICU, NICU, before invasive procedures.

التعريف: بالماء والصابون المطهر.
المدة: 40–60 ث (بيتادين 2–3 د)
المطهّر: كلورهيكسيدين 4%، بيتادين 7.5%
الهدف: المؤقتة + جزء من الدائمة
متى: ICU، NICU، قبل الإجراءات الاختراقية.

 Quick Tip: Types 1 & 2 use **water + soap**. Types 3 & 4 (next page) are more intensive.

 نصيحة: النوعين 1 و 2 بيستخدموا **ماء + صابون**. النوعين 3 و 4 (الصفحة الجاية) أكثر كثافة.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 11 ▪ CDC (2023).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Types 3 & 4: Surgical Scrub & ABHR / الأنواع 3 و 4

TYPE 3: Surgical Hand Scrub | النوع 3: الغسيل الجراحي

Definition: Highest level — pre-operative antisepsis.
Duration: 2–6 min (Betadine 3–5 min)
Agent: Chlorhexidine 4% / Betadine 7.5%
Coverage: Hands, wrists, up to elbows
When: Before all surgical procedures.
Why: Any microbe in wound = SSI.

التعريف: أعلى مستوى — قبل العمليات.
المدة: 2–6 دقائق (بيتادين 3–5 د)
المطهّر: كلورهيكسيدين 4% / بيتادين 7.5%
التغطية: الأيدي، الرسغ، لحد الكوع
متى: قبل العمليات.
ليه: أي ميكروب في الجرح = عدوى SSI.

TYPE 4: Alcohol-Based Hand Rub (ABHR) | النوع 4: التعقيم بالكحول

Definition: Waterless alcohol solution.
Duration: 20–30 seconds
Composition: Ethanol/Isopropyl 60–95% + glycerin
Kills: Bacteria, viruses, fungi
Does NOT kill: Spores (C. difficile)
When: First-line choice in most situations.

التعريف: محلول كحولي بدون ماء.
المدة: 20–30 ثانية
التركيب: إيثانول/أيزوبروبيل 60–95% + جلسرين
يقتل: بكتيريا، فيروسات، فطريات
لا يقتل: الجراثيم المُبَوَّغة (C. difficile)
متى: الخيار الأول في معظم الحالات.

⚠ **Critical:** Alcohol does NOT kill C. difficile spores — use soap & water with diarrhea patients!

⚠ **حرج:** الكحول ما يقتلش جراثيم C. difficile — استخدم ماء وصابون مع مرضى الإسهال!

 Golden Rule: Visibly dirty hands = **soap & water**. Clean but need decontamination = **alcohol**.

 قاعدة ذهبية: أيدي متسخة مرئياً = **ماء وصابون**. نضيفة بس محتاجة تطهير = **كحول**.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 12 • CDC ABHR Guidelines (2023).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Essential Equipment / المستلزمات الأساسية

What You Need: Proper equipment ensures effective hand hygiene. Missing supplies is a common reason for non-compliance.

المستلزمات: توفر الأدوات المناسبة يضمن نظافة أيدي فعّالة. نقص المستلزمات من أشهر أسباب عدم الالتزام.

- **Sink w/ Running Water** — حوض بماء جاري — يُفضَّل Sensor
- **Liquid Soap** — Wall-mounted — صابون سائل — تغيير كل 24 ساعة
- **Antiseptic Solution** — محلول مطهر — كلورهيكسيدين/بيتادين
- **ABHR Dispenser** — At bedside — موزع كحول — عند كل سرير
- **Paper Towels** — Single-use — فوط ورقية — استخدام واحد
- **Air Dryer** — Optional — مجفف هواء — اختياري
- **Nail Brush** — Sterile only — فرشاة أظافر — معقمة للجراحي
- **Waste Bin** — Foot-operated — سلة مهملات — بضغطة قدم
- **Moisturizer** — Water-based — مرطب — مائي يمنع الجفاف
- **WHO Poster** — Above sinks — بوستر WHO — فوق كل حوض

⚠ **NEVER Use:** Bar soap (bacterial contamination), reusable cloth towels, artificial nails, or nail polish.

⚠ **ممنوع تماماً:** الصابون الصلب، الفوط القماشية المشتركة، الأظافر الصناعية.

Tip: Missing ABHR at bedside = #1 reason for missed hand hygiene opportunities.

نصيحة: غياب الكحول عند سرير المريض = السبب الأول لتفويت لحظات النظافة.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 14 • CDC (2023).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

11 — Indications for Hand Hygiene دواعي نظافة الأيدي

When Exactly Should You Perform Hand Hygiene? / إمتى بالظبط لازم تعمل نظافة أيدي؟

Before Patient Contact:
- Before touching any patient
- Before donning gloves for aseptic procedures
- Before preparing IV solutions

قبل التعامل مع المريض:
- قبل لمس أي مريض
- قبل لبس الجوانتي للإجراءات المعقمة
- قبل تحضير المحاليل

After Body Fluid Exposure:
- Blood, urine, stool, vomit, wound drainage
- Even when gloves were worn
- After suctioning, oral care

بعد التعرض لسوائل الجسم:
- دم، بول، براز، قيء، صديد الجروح
- حتى لو كنت لابس جوانتي
- بعد الشفط، العناية بالفم

After Patient Contact:
- After any touch
- After removing gloves
- Before leaving patient's room

بعد التعامل مع المريض:
- بعد أي لمسة
- بعد خلع الجوانتي
- قبل الخروج من غرفة المريض

After Touching Patient Surroundings:
- Bed, side table, equipment
- Chart, phone, keyboard
- Even if you didn't touch patient

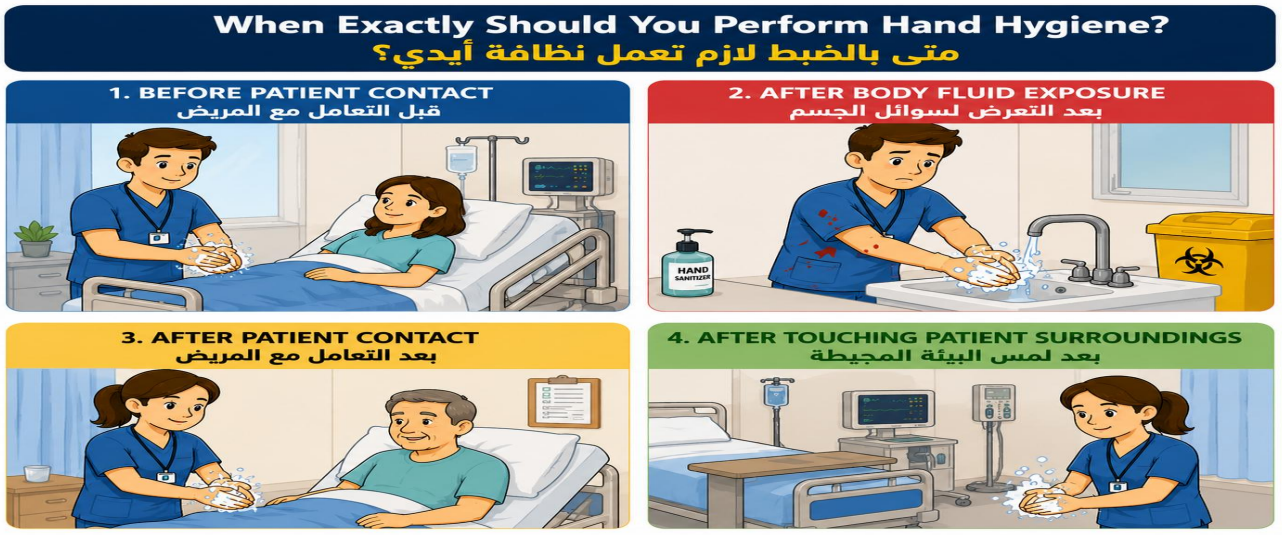
بعد لمس البيئة المحيطة:
- السرير، الترايزة، الأجهزة
- الشارت، الموبايل، الكيبورد
- حتى لو ما لمستش المريض

Daily Routine Situations:
- Before & after meals
- After using toilet
- After coughing, sneezing

المواقف اليومية:
- قبل وبعد الأكل
- بعد الحمام
- بعد الكحة، العطس

Golden Rule: If in doubt → wash! Extra 40 seconds is better than fatal infection.

القاعدة الذهبية: لو مش متأكد ← اغسل! 40 ثانية زيادة أفضل من عدوى قاتلة.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

5 The Gold Standard Framework — Never Miss a Moment! / المعيار الذهبي

 Why the 5 Moments? WHO created this framework to transform hand hygiene from a random act into an organized, evidence-based practice. It's not just about washing hands — but washing at the **RIGHT moment**.

 ليه اللحظات الخمس؟ WHO عملت المفهوم ده علشان تحوّل غسل الأيدين من تصرّف عشوائي لحاجة منظمة.
الأهم مش إنك تغسل، بل إنك تغسل في **اللحظة الصح**.

1 BEFORE Touching the Patient — قبل لمس المريض

When: Before any patient contact (physical exam, pulse, positioning).
Why: Your hands may be contaminated from another patient.
Goal: **Protect the patient** from external microbes.

إمتى: قبل أي لمسة للمريض (فحص، نبض، ترتيب سرير).
ليه: إيدك ممكن تكون ملوثة من مريض تاني.
الهدف: **حماية المريض** من الميكروبات الخارجية.

2 BEFORE Clean/Aseptic Procedure — قبل أي إجراء نظيف أو معقم

When: Before IV cannulation, wound dressing, catheter insertion.
Why: Any tiny microbe can enter bloodstream directly. Highest risk!
Goal: **Prevent infection** during procedures.

إمتى: قبل تركيب كانيولا، تغيير جرح، إدخال قسطرة.
ليه: أي ميكروب صغير ممكن يدخل الدم مباشرة.
الهدف: **منع العدوى** أثناء الإجراءات.

3 AFTER Body Fluid Exposure Risk — بعد التعرض لسوائل الجسم

When: After exposure to blood, urine, stool, vomit, wound drainage.
Even if: You wore gloves (not 100% barrier).
Goal: **Protect the healthcare worker**.

إمتى: بعد التعرض لدم، بول، براز، قيء، صديد جرح.
حتى لو: كنت لابس جوانتي (مش حاجز 100%).
الهدف: **حماية الفريق الطبي**.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Moments 4 & 5 + Common Pitfalls / اللحظات 4-5 والأخطاء الشائعة

4 AFTER Touching the Patient — بعد لمس المريض

When: After ANY patient contact — even simple touch.
Even if: No blood, no fluids — just handshake.
Why: Patient may be a carrier; skin contact transfers microbes.
Goal: 🎯 **Protect yourself and others**.

إمتى: بعد أي لمسة للمريض — حتى لو عادية.
حتى لو: مافيش دم أو سوائل — مجرد سلام.
ليه: المريض ممكن يكون حامل ميكروبات؛ اللمس ينقلها.
الهدف: 🎯 **حماية نفسك والآخرين**.

5 AFTER Touching Patient Surroundings — بعد لمس محيط المريض

When: After touching bed, table, equipment — WITHOUT touching patient.
Why: Environment is contaminated; microbes survive for hours to days.
Goal: 🎯 **Prevent cross-contamination**. This is the **most forgotten moment!**

إمتى: بعد لمس السرير، الترابيزة، الأجهزة — بدون لمس المريض.
ليه: البيئة ملوثة غالباً؛ الميكروبات تعيش لساعات أو أيام.
الهدف: 🎯 **منع التلوث المتقاطع**. دي **أكتر لحظة بتتنسي!**

⚠ Common Mistakes: — ⚠ أخطاء شائعة:

- Focusing only on Moment 3 — forgetting 1, 2, 4, 5.
- Relying on gloves instead of hand hygiene.
- Washing at wrong times.
- Skipping Moment 5 (surroundings).

- التركيز على اللحظة 3 فقط — ونسيان 1، 2، 4، 5.
- الاعتماد على الجوانتي بدل النظافة.
- الغسيل في وقت غلط.
- تجاهل اللحظة 5 (المحيط).

🏥 Critical Areas: — 🏥 الأقسام الحرجة:

- **ICU:** 100% compliance — no exceptions.
- **ER:** High stress but higher risk.
- **NICU:** Any missed moment = potentially fatal infection.

- **ICU:** الالتزام 100% — بدون استثناء.
- **ER:** ضغط عالي بس الخطر أعلى.
- **NICU:** أي لحظة مُهمَلة = عدوى قاتلة محتملة.

Source: WHO 5 Moments Poster (2023) • Sax H et al., J Hosp Infect (2007).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

11 The Standardized 11-Step WHO Technique / الخطوات الـ 11 المعتمدة

Master These 11 Steps: Following the standardized technique ensures every surface of your hands is cleaned. Missing any step leaves a "safe haven" for microbes.

اتقن الخطوات الـ 11: اتباع الخطوات المعتمدة يضمن تنظيف كل سطح في إيدك. أي خطوة تنساها = مكان آمن للميكروبات.

0 Wet hands with water بلل الإيدين بالماء	**1** Apply enough soap حط كمية صابون كافية	**2** Palm to palm افرك كف على كف
3 Right palm over left dorsum افرك ظهر الكف والعكس	**4** Palm to palm with fingers interlaced كف على كف مع تشابك الأصابع	**5** Backs of fingers to opposing palms ظهر الأصابع في راحة اليد المقابلة
6 Rotational rub of left thumb افرك إبهام الشمال دائري	**7** Rotational rub of right thumb افرك إبهام اليمين دائري	**8** Fingertips to left palm أطراف الأصابع في اليد اليسرى
9 Fingertips to right palm أطراف الأصابع في اليد اليمنى	**10** Rinse hands with water اشطف الإيدين بالماء	**11** Dry with single-use towel جفف بفوطة استخدام واحد

Duration: 40–60 seconds total. Each step ~5 sec. Rushing = incomplete cleaning.

المدة: 40–60 ثانية إجمالي. كل خطوة ~5 ثواني. السرعة = تنظيف ناقص.

Most Missed Areas: Thumbs, fingertips, between fingers, back of hands.

الأماكن اللي بتتنسي: الإبهام، أطراف الأصابع، بين الأصابع، ظهر الإيد.

For ABHR: Same technique (Steps 1-9), skip Step 0 & Steps 10-11. Rub until dry.

للكحول: نفس التقنية (خطوات 1-9)، اتخطى الخطوة 0 و 10-11. افرك لحد ما يجف.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 11 • WHO Poster (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

14 — Hand Washing Procedure إجراء غسيل الأيدي الروتيني

Routine Hand Washing — Step by Step / الغسيل الروتيني خطوة بخطوة

1	**Wet** hands thoroughly with clean warm running water.	**بلل** الإيدين بالماء الجاري الدافئ.
2	**Apply** enough liquid soap (3–5 mL).	**حط** كمية كافية من الصابون السائل.
3	**Rub** palm to palm in circular motion (5 sec).	**افرك** كف على كف دائري (5 ثواني).
4	**Rub** right palm over back of left hand with interlaced fingers.	**افرك** راحة اليمين على ظهر الشمال مع تشابك.
5	**Interlace** fingers palm-to-palm and rub.	**اشبك** الأصابع كف لكف وافرك.
6	**Rub** backs of fingers against opposing palms.	**افرك** ظهر الأصابع في راحة اليد المقابلة.
7	**Rotate** each thumb clasped in opposite palm.	**لف** كل إبهام في راحة اليد المقابلة.
8	**Rub** fingertips in opposite palm (rotational).	**افرك** أطراف الأصابع في راحة اليد المقابلة.
9	**Rinse** thoroughly. Keep hands LOWER than elbows.	**اشطف** جيداً. الإيدين تحت مستوى الكوع.
10	**Dry** completely with single-use paper towel.	**جفف** بالكامل بفوطة استخدام واحد.
11	**Close** tap using paper towel (NOT with clean hand!).	**اقفل** الحنفية بالفوطة (مش بإيدك النضيفة!).

 Total Duration: 40–60 seconds ▪ **Water:** Warm ▪ **Soap:** Liquid preferred.

 المدة الكلية: 40–60 ثانية ▪ **الماء:** دافئ ▪ **الصابون:** السائل مفضل.

Source: WHO How to Handwash Poster (2023) ▪ CDC Hand Washing Steps.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

15 — Antiseptic Hand Wash | الغسيل الصحي بالمُطهّرات

Hygienic Wash with Antimicrobial Soap / الغسيل بصابون مطهر

Definition: Washing hands with water and **antimicrobial soap** (Chlorhexidine, Betadine, Triclosan). Kills transient + partial resident flora.

التعريف: غسل الأيدي بالماء والصابون **المطهر** (كلورهيكسيدين، بيتادين). يقتل الميكروبات المؤقتة وجزء من الدائمة.

1	**Remove**all jewelry, watches, rings.	**اخلع**الإكسسوارات، الساعات، الخواتم.
2	**Wet**hands and forearms with warm water.	**بلل**الإيدين والساعدين بالماء الدافئ.
3	**Apply**antiseptic (Chlorhexidine 4% / Betadine 7.5%).	**حط**المطهر (كلورهيكسيدين 4% / بيتادين 7.5%).
4	**Perform**the 11-step WHO technique thoroughly.	**طبّق**خطوات الـ 11 الخاصة بـ WHO.
5	**Duration:**40–60 sec (Betadine 2–3 min).	**المدة:**40–60 ث (بيتادين 2–3 د).
6	**Rinse**thoroughly, hands lower than elbows.	**اشطف**جيداً، الإيدين تحت الكوع.
7	**Dry**with sterile single-use towel.	**جفف**بفوطة معقمة استخدام واحد.

Indications:	الاستخدامات:
ICU / NICU — Before & after patient contact.	**ICU / NICU** — قبل وبعد التعامل مع المريض.
Invasive Procedures — IV, catheter, feeding tube.	**الإجراءات الاختراقية** — كانيولا، قسطرة.
Isolation Patients — After contact with isolated patient.	**مرضى العزل** — بعد التعامل مع مريض معزول.
Body Fluid Exposure — After blood/fluid exposure.	**التعرض للسوائل** — بعد التعرض لدم أو سوائل.
Immunocompromised — Before care of high-risk patients.	**ضعيفي المناعة** — قبل رعاية المرضى الخطرين.

Source: WHO Guidelines (2009) ▪ CDC Antiseptic Recommendations (2023).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

16 — Surgical Hand Scrub ★ الغسيل الجراحي

Highest Level of Hand Hygiene — Pre-Operative / أعلى مستوى نظافة

What is Surgical Scrub? The highest level — performed before entering OR to **eliminate transient flora completely** and **significantly reduce resident flora**. Any microbe in surgical wound = SSI.

ما هو الغسيل الجراحي؟ أعلى مستوى — بيتعمل قبل الدخول لغرفة العمليات لـ**إزالة الميكروبات المؤقتة بالكامل**. أي ميكروب في الجرح = عدوى SSI.

1	**Remove**jewelry, artificial nails. Wear cap & mask first.	**اخلع** الإكسسوارات، الأظافر الصناعية. البس البونيه والماسك أولاً.
2	**Open**sterile scrub pack & sterile towels.	**افتح** السكرب باك المُعَقَّم والفوط المُعَقَّمة.
3	**Wet**hands, wrists, forearms up to elbows.	**بلل** الإيدين، الرسغين، الساعدين لحد الكوعين.
4	**Apply**Chlorhexidine 4% or Betadine 7.5%.	**حط** كلورهيكسيدين 4% أو بيتادين 7.5%.
5	**Clean nails**with sterile nail pick under water.	**نظّف الأظافر** بمنظف أظافر معقم تحت الماء.
6	**Scrub**each finger, palm, back of hand — 2 min per hand.	**افرك** كل صباع، الكف، ظهر الإيد — 2 دقيقة لكل إيد.
7	**Scrub**forearms up to elbows — 1 min each.	**افرك** الساعدين لحد الكوعين — دقيقة لكل ذراع.
8	**Rinse**— always keeping hands ABOVE elbows.	**اشطف** — الإيدين دايماً فوق الكوعين.
9	**Dry**with sterile towel — fingertips to elbow.	**جفف** بفوطة معقمة — من الأصابع للكوع.
10	**Enter**OR with hands elevated. Don sterile gown & gloves.	**ادخل** العمليات والإيدين مرفوعة. البس الجاون والجوانتي المُعَقَّم.

Duration: Chlorhexidine 3–5 min ▪ Betadine 3–5 min ▪ Alcohol surgical rub 1.5–3 min.

المدة: كلورهيكسيدين 3–5 د ▪ بيتادين 3–5 د ▪ كحول جراحي 1.5–3 د.

⚠ **Critical Rules:** Hands ALWAYS above elbows ▪ Never touch non-sterile ▪ If contaminated → RESTART.

⚠ **قواعد حرجة:** الإيدين دايماً فوق الكوع ▪ لا تلمس أي غير معقم ▪ لو اتلوثت ← ابدأ من الأول.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Alcohol-Based Hand Rub — Fast & Effective / سريع وفعّال

First-Line Choice: ABHR is faster (20-30 sec vs 40-60 sec), more effective than plain soap, and less irritating. WHO's preferred method except when hands are visibly soiled.

الخيار الأول: الكحول أسرع (20-30 ث بدل 40-60)، أكثر فعالية من الصابون العادي، وأقل تهييجاً.

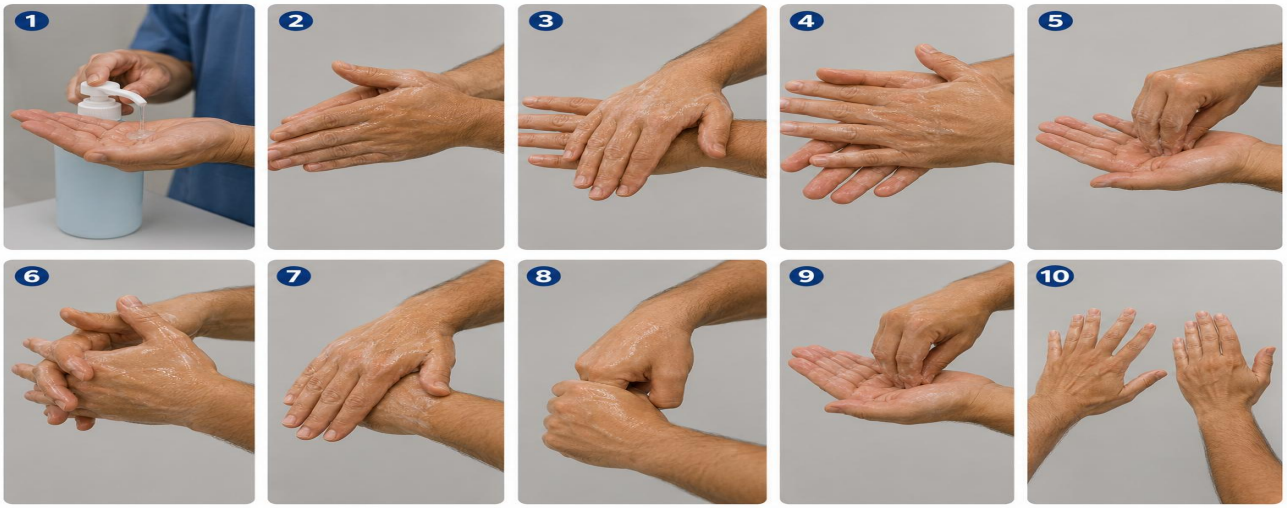
1	**Ensure**hands are NOT visibly soiled. If dirty → wash first.	**تأكد**إن الإيدين مش متسخة مرئياً. لو متسخة ← اغسل أولاً.
2	**Apply**a palmful (3–5 mL) of ABHR.	**حط**ملء الكف (3–5 مل) من الكحول.
3	**Cover**all surfaces of both hands.	**غطي**كل أسطح الإيدين.
4	**Rub**palm to palm in circular motion.	**افرك**كف على كف دائري.
5	**Rub**right palm over back of left hand + reverse.	**افرك**راحة اليمين على ظهر الشمال + العكس.
6	**Interlace**fingers palm-to-palm and rub.	**اشبك**الأصابع كف لكف وافرك.
7	**Rub**backs of fingers on opposing palms.	**افرك**ظهر الأصابع في الراحة المقابلة.
8	**Rotate**each thumb in opposite palm.	**لف**كل إبهام في الراحة المقابلة.
9	**Rub**fingertips in opposite palm.	**افرك**أطراف الأصابع في الراحة المقابلة.
10	**Continue**rubbing until completely DRY (20–30 sec).	**استمر**في الفرك لحد ما تجف تماماً (20–30 ث).

⚠ Do NOT Use ABHR When:
▪ Hands visibly soiled ▪ After C. difficile patient ▪ Before eating

⚠ لا تستخدم الكحول:
▪ لو الإيدين متسخة مرئياً ▪ بعد مريض C. difficile ▪ قبل الأكل

Disadvantages: Causes dryness with frequent use ▪ Doesn't work on visible dirt ▪ Doesn't kill spores

العيوب: يسبب جفاف مع الاستخدام المتكرر ▪ لا يعمل مع الاتساخ الظاهر ▪ لا يقتل الجراثيم المُبَوَّغة



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

18 — Scientific Rationales التسويغ العلمي

? **The "WHY" Behind Every Step / السبب العلمي وراء كل خطوة**

✓ **Why remove jewelry and rings?**	✓ **ليه بنشيل الإكسسوارات والخواتم؟**
Reason: *Rings harbor* **10x more bacteria** *than bare skin.*	**السبب:** *الخواتم بتحتوي* **10 أضعاف البكتيريا** *على الجلد.*
✓ **Why wet hands BEFORE applying soap?**	✓ **ليه بنبل الإيد قبل الصابون؟**
Reason: *Water activates soap's emulsifying properties.*	**السبب:** *الماء بينشط خصائص الصابون.*
✓ **Why wash for at least 40 seconds?**	✓ **ليه لازم 40 ثانية على الأقل؟**
Reason: *Minimum time for soap to remove* **99% of transient flora**.	**السبب:** *أقل وقت لإزالة* **99% من الميكروبات المؤقتة**.
✓ **Why interlace fingers?**	✓ **ليه بنشبك الأصابع؟**
Reason: *Interdigital spaces are* **most bacteria-rich areas**.	**السبب:** *بين الأصابع* **أكتر الأماكن بالبكتيريا**.
✓ **Why rinse with hands LOWER than elbows?**	✓ **ليه الإيدين تحت الكوع في الشطف؟**
Reason: *Prevents contaminated water from flowing back onto clean hands.*	**السبب:** *يمنع الماء الملوث من الرجوع للإيدين النضيفة.*
✓ **Why hands ABOVE elbows in Surgical Scrub?**	✓ **ليه فوق الكوع في الجراحي؟**
Reason: *Water flows down from cleanest area (fingertips) — protecting sterility.*	**السبب:** *الماء ينزل من الأنضف (الأصابع) — يحمي التعقيم.*
✓ **Why use paper towel to close tap?**	✓ **ليه بنستخدم فوطة لغلق الحنفية؟**
Reason: *Tap handle is* **heavily contaminated**.	**السبب:** *يد الحنفية* **ملوثة جداً**.
✓ **Why alcohol 60–95%, not 100%?**	✓ **ليه الكحول 60-95% مش 100%؟**
Reason: *100% alcohol* **evaporates too fast** *before killing microbes.*	**السبب:** *الكحول 100% يتبخر بسرعة قبل ما يقتل الميكروب.*
✓ **Why is drying so critical?**	✓ **ليه التجفيف مهم جداً؟**
Reason: *Wet hands transfer bacteria* **1000x more** *than dry.*	**السبب:** *الإيد الرطبة تنقل بكتيريا* **ألف ضعف** *الجافة.*

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 5 ▪ Boyce & Pittet MMWR (2002).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

19 — Hand Drying Techniques تجفيف الأيدي

Drying Is as Important as Washing! / التجفيف مهم زي الغسيل!

Why is Drying Critical? Wet hands transfer bacteria **1,000 times more** than dry hands. Moisture is a perfect breeding ground for microbes.

ليه التجفيف مهم؟ الإيد الرطبة بتنقل بكتيريا **ألف ضعف** الجافة. الرطوبة بيئة مثالية لنمو الميكروبات.

Method / الطريقة	Pros / المميزات	Cons / العيوب
Paper Towels فوط ورقية	✓ Most hygienic; fast ✓ الأكثر نظافة؛ سريع	✗ Environmental waste; Cost ✗ نفايات بيئية؛ التكلفة
Sterile Cloth قماش معقم	✓ For surgical scrub only ✓ للغسيل الجراحي فقط	✗ Not for daily use ✗ ليس للاستخدام اليومي
Air Dryer مجفف هواء	✓ Hands-free; Eco-friendly ✓ بدون لمس؛ صديق للبيئة	✗ Slow; Can spread bacteria ✗ بطيء؛ ممكن ينشر البكتيريا
Shared Cloth قماش مشترك	**✗ NEVER USE — Spreads infection! / ✗ ممنوع تماماً — بينقل عدوى!**	

✓ Rules for Paper Towels:
- Single-use, placed away from sink
- Hands-free dispenser preferred
- Use ONE towel to dry, SECOND to close tap

✓ قواعد الفوط الورقية:
- استخدام واحد، بعيدة عن الحوض
- موزع بدون لمس مفضل
- فوطة للتجفيف، وتانية لغلق الحنفية

The Rule: Wet hands are more dangerous than contaminated hands.

القاعدة: الإيد الرطبة أخطر من الملوثة.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 13 • Mayo Clinic Proc (2012).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

20 — Hand Hygiene with Gloves نظافة الأيدي مع الجوانتي

CRITICAL: Wearing Gloves ≠ Hand Hygiene / لبس الجوانتي مش بديل عن الغسيل

⚠ Wearing gloves ≠ Hand Hygiene

One of the biggest mistakes healthcare workers make is thinking gloves substitute hand hygiene. This is **WRONG and DANGEROUS**.

⚠ لبس الجوانتي مش بديل عن غسل الإيدين!

من أكبر الأخطاء اللي بيعملها الفريق الطبي إنهم يفتكروا إن الجوانتي بديل. **ده غلط وخطير جداً**.

Why Gloves Are NOT Enough:

- Invisible **micro-tears** can exist
- Gloves get **contaminated** during use
- Microbes multiply **underneath** (warm, moist)
- Contamination during **removal**
- No glove is 100% impermeable

ليه الجوانتي لوحده مش كافي؟

- ممكن يكون فيه **ثقوب صغيرة** غير مرئية
- بيتلوث أثناء الاستخدام
- الميكروبات تنمو **تحته**
- التلوث بيحصل أثناء **الخلع**
- مافيش جوانتي 100% غير منفذ

✓ Golden Rule:

Hand hygiene BEFORE wearing gloves

+

Hand hygiene AFTER removing gloves

Both mandatory — no exceptions!

✓ القاعدة الذهبية:

نظافة الأيدي قبل لبس الجوانتي

+

نظافة الأيدي بعد خلعه

الاتنين واجبين — بدون استثناءات!

When to Wear Gloves?

- Contact with blood or body fluids expected
- Handling contaminated surfaces
- Patients on contact precautions
- Sterile procedures (sterile gloves)

إمتى نلبس الجوانتي؟

- توقع تلامس مع دم أو سوائل
- التعامل مع أسطح ملوثة
- مرضى الاحتياطات التلامسية
- الإجراءات المعقمة

⚠ Common Mistake: Wearing same pair of gloves between patients! Each patient = new pair + hand hygiene.

⚠ خطأ شائع: لبس نفس الجوانتي بين مريض ومريض! كل مريض = زوج جديد + نظافة أيدي.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 17 ▪ CDC Glove Recommendations (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Healthy Skin = Better Compliance / الجلد الصحي = التزام أفضل

Why Skin Care Matters: Frequent hand hygiene can cause dry, cracked skin — reducing compliance, more microbes hiding in cracks, higher infection risk.

ليه العناية بالجلد مهمة؟ نظافة الأيدي المتكررة ممكن تسبب جفاف وتشقق — يقلل الالتزام، ميكروبات تختبئ في الشقوق.

Effects of Damaged Skin:
- Cracked skin = "Portal of entry" for microbes
- Painful hand hygiene → reduced compliance
- Increased colonization of resistant bacteria
- Higher risk of contact dermatitis

لو الجلد اتشقق:
- يبقى مدخل مثالي للميكروبات
- غسل مؤلم ← الالتزام يقل
- زيادة استعمار البكتيريا المقاومة
- خطر أعلى للحساسية

Skin Protection Strategies:
- Use **ABHR** when possible (less irritating)
- Choose **mild pH-balanced soaps**
- Apply **water-based moisturizer** after each shift
- Use **lukewarm water** (never hot)
- Dry hands thoroughly

نصائح للحماية:
- استخدم **الكحول** كل ما أمكن
- اختار **صابون متعادل الحموضة**
- استخدم **مرطب مائي** بعد كل شيفت
- استخدم **ماء فاتر** (مش سخن)
- جفف كويس

Avoid:
- Petroleum-based moisturizers (damage gloves)
- Hot water for washing
- Rings, artificial & long natural nails
- Sharing moisturizer bottles

تجنّب:
- المرطبات البترولية (تدمّر الجوانتي)
- الماء السخن للغسيل
- الخواتم، الأظافر الصناعية والطويلة
- مشاركة زجاجات المرطب

Report to Occupational Health: Any skin problems — you may need alternative products.

بلّغ الصحة المهنية: أي مشاكل جلدية — ممكن تحتاج منتجات بديلة.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Documentation Standards / معايير التوثيق

What to Document: Hand hygiene is not routinely documented per patient. But institutional monitoring and compliance audits require documentation.

إيه اللي بيتوثّق؟ نظافة الأيدي مش بتتوثق لكل مريض روتيني. لكن المراقبة المؤسسية بتحتاج توثيق.

✓ Institutional Documentation:
- **Compliance rate** per unit (monthly audits)
- **Training records** (annual mandatory)
- **Product availability** reports
- **Skin condition** assessments
- **Compliance audit** reports

✓ التوثيق المؤسسي:
- **نسبة الالتزام** لكل قسم (شهرياً)
- **سجلات التدريب** (سنوي إلزامي)
- **تقارير توفر المنتجات**
- **تقييم حالة الجلد**
- **تقارير المراجعة**

WHO Compliance Formula:
Compliance % = (Actions ÷ Opportunities) × 100
- Actions = HH correctly performed
- Opportunities = HH was indicated
- Target: **≥ 80%** in all units

معادلة WHO للالتزام:
الالتزام % = (المرات المُنَفَّذة ÷ الفرص) × 100
- المُنَفَّذة = نظافة تمت بشكل صحيح
- الفرص = كان لازم نظافة أيدي
- الهدف: **80%** فأكتر

Individual Documentation:
- Surgical scrub → document time & duration
- Skin reactions → occupational health
- Equipment malfunction → incident report

التوثيق الفردي:
- الغسيل الجراحي ← وثّق الوقت والمدة
- الحساسية ← بلّغ الصحة المهنية
- عطل الأجهزة ← تقرير حادث

⚠ **Never Falsify:** Fake compliance data = patient harm. Report truthfully.

⚠ **لا تزوّر أبداً:** تزوير بيانات الالتزام = ضرر للمريض.

Source: WHO Hand Hygiene Compliance Tool (2009) ▪ Joint Commission NPSG (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

23 — Infection Control Standards معايير مكافحة العدوى

National & International Standards / المعايير الوطنية والدولية

Organization / المنظمة	Standard / المعيار
WHO منظمة الصحة العالمية	Guidelines on Hand Hygiene (2009) — Global Gold Standard إرشادات نظافة الأيدي — المعيار الذهبي العالمي
CDC مركز مكافحة الأمراض	Guideline for Hand Hygiene in Healthcare (2023) دليل نظافة الأيدي في المنشآت الصحية
Joint Commission اللجنة المشتركة	National Patient Safety Goal (NPSG.07.01.01) هدف سلامة المريض الوطني
APIC الجمعية الأمريكية	Association for Professionals in Infection Control جمعية المهنيين في مكافحة العدوى
Egyptian MOH وزارة الصحة المصرية	National IPC Manual (Chapter 3) دليل مكافحة العدوى الوطني — الفصل الثالث
GAHAR هيئة الاعتماد المصرية	General Authority for Healthcare Accreditation الهيئة العامة لاعتماد المنشآت الصحية

 Standard Precautions Include: Hand hygiene is **the #1 Standard Precaution** — applied to every patient, every time. Part of a bigger system: PPE, safe injections, environmental cleaning, respiratory hygiene.

 الاحتياطات القياسية تشمل: نظافة الأيدي هي **أول احتياط قياسي** — بتنطبق على كل مريض. جزء من نظام أكبر: PPE، حقن آمنة، تنظيف بيئي.

 Bottom Line: Hand hygiene is the foundation of any strong infection control program. Without it, all other measures fail.

 خلاصة: نظافة الأيدي أساس أي برنامج قوي لمكافحة العدوى. بدونها، كل الإجراءات التانية بتفشل.

Sources: WHO (2009) ▪ CDC (2023) ▪ Joint Commission ▪ Egyptian MOH ▪ GAHAR.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Special Considerations for Critical Care / اعتبارات خاصة للأقسام الحرجة

Why Critical Areas Need Extra Attention? Patients in ICU, NICU, and OR are highly vulnerable — minor infection can be fatal. Compliance requirements are stricter.

ليه الأقسام الحرجة محتاجة اهتمام أكبر؟ المرضى في ICU و NICU وغرفة العمليات ضعاف جداً — عدوى بسيطة ممكن تكون قاتلة.

ICU (Adult Intensive Care):
- **100% compliance required** — no exceptions
- ABHR at every bedside & entry/exit
- Between every intervention
- Higher risk: VAP, CLABSI, CAUTI

ICU (العناية المركزة):
- **الالتزام 100%** — بدون استثناءات
- كحول عند كل سرير
- بين كل إجراء (خطوط، شفط، تغذية)
- خطر أعلى: VAP، CLABSI، CAUTI

NICU (Neonatal ICU):
- **Highest risk area** — any missed moment = fatal
- Full hand wash on entry (2 min) + ABHR before every touch
- No rings, watches, artificial nails
- Neonatal sepsis mortality up to **40%**

NICU (عناية حديثي الولادة):
- **أخطر منطقة** — أي لحظة مُهمَلة = قاتلة
- غسيل كامل عند الدخول (2 د) + كحول قبل كل لمسة
- ممنوع خواتم، ساعات، أظافر صناعية
- وفيات عدوى حديثي الولادة لحد **40%**

Operating Room (OR):
- Surgical scrub mandatory before every case
- Duration: 3–5 min (Betadine) or 1.5–3 min (alcohol rub)
- Hands above elbows after scrubbing
- Re-scrub if contamination occurs
- Any breach = SSI risk

غرفة العمليات (OR):
- الغسيل الجراحي إلزامي قبل كل عملية
- المدة: 3–5 د (بيتادين) أو 1.5–3 د (كحول)
- الإيدين فوق الكوع بعد الغسيل
- إعادة الغسيل لو حصل تلوث
- أي إخلال = خطر عدوى SSI

Emergency Room (ER):
- High patient turnover — stress increases missed moments
- ABHR is your best friend (fast, effective)
- Standard precautions for every patient
- Extra vigilance with trauma cases

الطوارئ (ER):
- معدل مرضى عالي — الضغط يزيد اللحظات المنسية
- الكحول صاحبك المفضل (سريع، فعّال)
- احتياطات قياسية لكل مريض
- يقظة زيادة مع حالات الحوادث

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 20 • CDC HAI Prevention (2023) • AORN Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Top 10 Mistakes During Hand Hygiene / أشهر 10 أخطاء أثناء غسل الأيدي

The Real Problem: The problem isn't that people don't wash — it's that they wash **WRONG**. Any small mistake can nullify the benefit of washing completely.

المشكلة الحقيقية: المشكلة مش إن الناس مش بتغسل — لكن إنها بتغسل **غلط**. أي خطأ صغير ممكن يلغي فايدة الغسيل تماماً.

1 Short Duration Washing — الغسيل لمدة أقل من المطلوب

Problem: Washing hands in 5–10 seconds instead of 40–60.
Result: Transient flora is NOT fully removed. Microbes remain and transfer easily.

المشكلة: الغسيل في 5–10 ثواني بدل 40–60.
النتيجة: الميكروبات المؤقتة لا تُزال بالكامل.

2 Poor Hand Rubbing Technique — تقنية الفرك السيئة

Problem: Focusing only on palms, forgetting back of hand, between fingers, thumbs, fingertips.
Result: These "high-risk areas" become bacteria hotspots.

المشكلة: التركيز على الكف فقط، ونسيان ظهر الإيد، بين الأصابع، الإبهام.
النتيجة: الأماكن دي بتبقى بؤر بكتيريا.

3 Ignoring Thumbs & Fingernails — تجاهل الإبهام وتحت الأظافر

Problem: Thumb is the most forgotten. Long/artificial nails harbor massive bacteria.
Danger: Can cause fatal infections in ICU and NICU.

المشكلة: الإبهام من أكتر الأماكن اللي بتتنسي. الأظافر الطويلة تحتوي على بكتيريا كتيرة.
الخطر: ممكن يسبب عدوى قاتلة.

4 Using Water Only (No Soap) — استخدام الماء فقط بدون صابون

Problem: Water alone doesn't break skin oils or remove microbes attached to skin.
Truth: Water alone = feeling of cleanliness, NOT real cleanliness.

المشكلة: الماء وحده ما بيكسرش الدهون أو الميكروبات.
الحقيقة: ماء فقط = إحساس نظافة، مش نظافة حقيقية.

5 Improper Soap Use — استخدام صابون غير مناسب

Problem: Very harsh soap → skin irritation. Non-medical soap → less effective.
Result: Cracked skin = **portal of entry** for microbes.

المشكلة: صابون قوي جداً ← تهييج الجلد. صابون مش طبي ← يقلل الفاعلية.
النتيجة: الجلد المتشقق = **مدخل للميكروبات**.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 16 • CDC Common Errors (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Mistakes 6-10: The Silent Killers / الأخطاء 6-10: القاتلة الصامتة

6 Inadequate Hand Drying — التجفيف غير الكافي

Problem: Wet hands after washing.
Danger: Wet hands transfer **1,000x more** bacteria than dry. Solution: Paper towels.

المشكلة: إيدين رطبة بعد الغسيل.
الخطر: الإيد الرطبة تنقل بكتيريا **1000 ضعف** الجافة.

7 Touching Faucet After Washing — لمس الحنفية بعد الغسيل

Problem: Washing hands, then closing tap with bare hands.
Result: Microbes return immediately! Use paper towel or sensor tap.

المشكلة: غسل الإيد، ثم قفل الحنفية بالإيد المجردة.
النتيجة: الميكروب يرجع فوراً!

8 Wrong Timing of Hand Washing — الغسيل في التوقيت الخطأ

Problem: Even correct washing has no benefit if done at wrong time.
Examples: Forgetting before patient contact. Solution: WHO 5 Moments.

المشكلة: حتى لو الغسيل صح، لو في وقت غلط ماله فايدة.
أمثلة: نسيان قبل لمس المريض.

9 Over-Reliance on Gloves — الاعتماد الزائد على الجوانتي

Problem: Some think wearing gloves eliminates the need for hand hygiene.
Wrong: Gloves can tear, get contaminated. Rule: HH before & after gloves.

المشكلة: بعض الناس يفتكروا إن لبس الجوانتي يغني عن غسل الإيدين.
غلط: الجوانتي ممكن يتثقب أو يتلوث.

10 Neglecting Skin Care — إهمال العناية بالجلد

Problem: Dry, cracked skin from frequent washing.
Result: Reduces compliance & increases infection. Use moisturizers.

The Golden Truth: The biggest problem in hand hygiene is not that people don't wash — but that they wash **WRONG**. Correct technique = real protection.

الحقيقة الذهبية: أكبر مشكلة في نظافة الأيدي مش إن الناس مش بتغسل — لكن إنها بتغسل **غلط**.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 16 • CDC Common Errors (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

26 — Red Flags | العلامات الحمراء (التحذيرية)

Warning Signs You Must Recognize / علامات التحذير اللي لازم تعرفها

What Are Red Flags? Warning signs indicating serious problems in hand hygiene requiring immediate action to prevent an infection outbreak.

إيه هي العلامات الحمراء؟ إشارات تحذيرية بتدل على مشاكل خطيرة في نظافة الأيدي بتستدعي تدخل فوري لمنع كارثة عدوى.

Personal Red Flags:	**علامات حمراء شخصية:**
▪ Persistent skin rash or dermatitis	▪ طفح جلدي أو حساسية مستمرة
▪ Cracked, painful skin	▪ جلد متشقق ومؤلم
▪ Allergic reaction to soap/ABHR	▪ حساسية من الصابون أو الكحول
▪ Unexplained fatigue or fever after work	▪ إرهاق أو حمى غير مبررة بعد الشغل
⚠ Departmental Red Flags:	**⚠ علامات حمراء بالقسم:**
▪ Sudden increase in HAIs in a unit	▪ ارتفاع مفاجئ في العدوى داخل قسم
▪ Compliance rate below 60%	▪ نسبة التزام أقل من 60%
▪ Empty ABHR dispensers frequently	▪ موزعات كحول فاضية باستمرار
▪ Multiple patients with same infection	▪ عدة مرضى بنفس العدوى
Emergency Red Flags (Immediate Action!):	**علامات حمراء طارئة (تدخل فوري!):**
▪ MRSA/VRE outbreak	▪ تفشي MRSA أو VRE
▪ C. difficile cluster	▪ مجموعة إصابات C. difficile
▪ Suspected needle stick injury	▪ إصابة إبرة مشكوك فيها
▪ Exposure to bloodborne pathogens	▪ تعرض لممرضات الدم
✓ Immediate Action Plan:	**✓ خطة التدخل الفوري:**
▪ Report to IPC team immediately	▪ بلّغ فريق IPC فوراً
▪ Isolate affected patients	▪ اعزل المرضى المصابين
▪ Increase surveillance	▪ زوّد المراقبة
▪ Refresher training for all staff	▪ تدريب تنشيطي لكل الموظفين
▪ Audit hand hygiene compliance	▪ راجع الالتزام
Golden Rule: Never ignore a red flag. Early recognition = early intervention = lives saved.	**قاعدة ذهبية:** لا تتجاهل علامة حمراء أبداً. الاكتشاف المبكر = تدخل مبكر = إنقاذ حياة.

Source: WHO Guidelines (2009) ▪ CDC Outbreak Investigation (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🚫 When NOT to Use Certain Types / إمتى ما تستخدمش بعض الأنواع

⚠ **Important Note:** There is NO true contraindication to hand hygiene itself — it's always required. But specific TYPES of hand hygiene have precautions.

⚠ **نقطة مهمة:** مافيش موانع مطلقة لنظافة الأيدي في حد ذاتها — دايماً مطلوبة. لكن أنواع معينة فيها احتياطات.

Situation / الحالة	Contraindicated / ممنوع	Alternative / البديل
C. difficile Patient **مريض C. difficile**	✗ Alcohol-Based Hand Rub ✗ التعقيم بالكحول	✓ Soap & Water only ✓ ماء وصابون فقط
Visibly Soiled Hands **أيدي متسخة مرئياً**	✗ ABHR alone ✗ الكحول لوحده	✓ Soap & Water first ✓ ماء وصابون أولاً
Alcohol Allergy **حساسية من الكحول**	✗ Any alcohol-based product ✗ أي منتج كحولي	✓ Non-alcohol antiseptic ✓ مطهر غير كحولي
Broken/Cut Skin **جلد مقطوع**	✗ Strong antiseptics (painful) ✗ مطهرات قوية (مؤلمة)	✓ Cover wound + mild soap ✓ غطي الجرح + صابون لطيف
Iodine Allergy **حساسية اليود**	✗ Betadine (povidone-iodine) ✗ البيتادين	✓ Chlorhexidine 4% ✓ كلورهيكسيدين 4%
Neonates **حديثي الولادة**	✗ Chlorhexidine on face/eyes ✗ كلورهيكسيدين على الوجه/العين	✓ Sterile water; ABHR for hands ✓ ماء معقم؛ كحول للأيدي

 Key Message: Hand hygiene is ALWAYS required — you just choose the right method for the situation. When in doubt, use soap and water.

 الرسالة الأساسية: نظافة الأيدي مطلوبة دايماً — بس تختار الطريقة المناسبة للموقف. لو مش متأكد، استخدم الماء والصابون.

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 18 • CDC Antiseptic Guidelines (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Hand Hygiene in Children & Neonates / نظافة الأيدي مع الأطفال

Why Extra Care? Children (especially neonates and infants) have immature immune systems. A minor infection can quickly become life-threatening.

ليه عناية زيادة؟ الأطفال (خاصة حديثي الولادة والرضع) عندهم جهاز مناعي غير مكتمل. عدوى بسيطة ممكن تبقى قاتلة بسرعة.

Neonates (0–28 days):
- Highest risk in NICU — mortality up to 40%
- Full hand wash on entry (2 min)
- ABHR before EVERY touch
- Avoid Chlorhexidine on face/eyes
- Absolutely NO rings, artificial nails

حديثي الولادة (0–28 يوم):
- أعلى خطورة في NICU — وفيات تصل 40%
- غسيل كامل عند الدخول (2 د)
- كحول قبل كل لمسة
- تجنب الكلورهيكسيدين على الوجه/العين
- ممنوع تماماً الخواتم والأظافر الصناعية

Infants (1–12 months):
- Immune system still developing
- Same NICU precautions apply
- Extra attention during feeding, diaper change
- Parents should also perform HH

الرضع (1–12 شهر):
- المناعة لسه بتتطور
- نفس احتياطات NICU
- اهتمام زيادة أثناء الرضاعة وتغيير الحفاض
- الوالدين لازم كمان يعملوا نظافة أيدي

Children (1–12 years):
- Teach children the technique early
- Make it fun (songs, colored soap)
- Supervise until age 6
- Emphasize before eating & after toilet

الأطفال (1–12 سنة):
- علّم الأطفال التقنية بدري
- خليها ممتعة (أغاني، صابون ملون)
- إشراف حتى سن 6
- ركّز قبل الأكل وبعد الحمام

Teaching Method for Children:
- "Happy Birthday" song = 20 seconds (sing twice)
- Use bubble/foam soap
- Reward system for compliance
- Lead by example

طريقة تعليم الأطفال:
- أغنية "Happy Birthday" = 20 ثانية (غنيها مرتين)
- استخدم صابون رغوة
- نظام مكافآت
- كن قدوة

Source: WHO Guidelines (2009), Chapter 20 • AAP Pediatric IPC (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Hand Hygiene in Geriatric Patients / نظافة الأيدي مع كبار السن

Why Special Care? Elderly patients have weakened immunity, thin fragile skin, and are highly susceptible to HAIs.

ليه عناية خاصة؟ كبار السن عندهم مناعة ضعيفة، جلد رقيق وحساس، ومعرضين جداً لعدوى المستشفيات.

Skin Fragility:
- Very thin, dry skin
- Prone to tears and bruises
- Use lukewarm water only
- Choose mild, moisturizing soap
- Pat dry gently (don't rub)

هشاشة الجلد:
- جلد رقيق جداً وجاف
- معرض للتمزق والكدمات
- استخدم ماء فاتر فقط
- اختار صابون لطيف مرطب
- جفف بالربت (مش الفرك)

Highest Risk Infections:
- Pneumonia (aspiration risk)
- UTI (from catheters)
- Pressure ulcer infections
- C. difficile diarrhea
- MRSA colonization

أخطر أنواع العدوى:
- الالتهاب الرئوي (خطر الاستنشاق)
- عدوى بولية (من القسطرة)
- عدوى قرح الفراش
- إسهال C. difficile
- استعمار MRSA

Practical Tips:
- Assist patients who cannot wash themselves
- Use wipes for bedridden patients
- Extra hygiene after diaper changes
- Extra hygiene before feeding
- Educate family caregivers

نصائح عملية:
- ساعد المرضى اللي مش قادرين يغسلوا
- استخدم مناديل مبللة للمرضى الطريحين
- نظافة زيادة بعد تغيير الحفاض
- نظافة زيادة قبل مساعدة الأكل
- علّم أهل المريض

Cognitive Considerations: Patients with dementia may resist hand washing. Use gentle approach, distraction, or wet wipes when needed.

الاعتبارات الإدراكية: مرضى الخرف ممكن يرفضوا الغسيل. استخدم أسلوب لطيف، إلهاء، أو مناديل مبللة.

Source: WHO Guidelines (2009) ▪ SHEA Long-Term Care IPC (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Hand Hygiene During Pregnancy / نظافة الأيدي أثناء الحمل

Why Extra Vigilance? Pregnant patients need extra protection because some infections can harm the fetus. Pregnant healthcare workers also need careful precautions.

ليه يقظة زيادة؟ الحوامل محتاجين حماية أكبر لأن بعض العدوى ممكن تضر الجنين. الممرضات الحوامل كمان محتاجين احتياطات دقيقة.

Infections Harmful to Fetus:
- CMV (Cytomegalovirus)
- Toxoplasmosis
- Rubella
- Parvovirus B19
- Varicella (chickenpox)

عدوى تضر الجنين:
- فيروس CMV
- داء المقوسات (Toxoplasmosis)
- الحصبة الألمانية
- فيروس Parvovirus B19
- الجدري المائي

⚠ Pregnant Healthcare Workers:
- Avoid caring for infectious patients when possible
- Strict hand hygiene BEFORE and AFTER each contact
- Use ABHR (fast & effective)
- Use protective gloves for high-risk situations
- Report exposures immediately

⚠ الممرضات الحوامل:
- تجنب رعاية المرضى المعديين قدر الإمكان
- نظافة صارمة قبل وبعد كل تعامل
- استخدم الكحول (سريع وفعّال)
- جوانتي حماية للحالات الخطرة
- بلّغ عن أي تعرض فوراً

Products Safety in Pregnancy:
- **Chlorhexidine 4%:** ✓ Safe
- **Alcohol-based rub:** ✓ Safe (external)
- **Betadine (Iodine):** ⚠ Use cautiously
- **Triclosan:** ✕ Avoid (crosses placenta)

سلامة المنتجات في الحمل:
- **كلورهيكسيدين 4%:** ✓ آمن
- **الكحول:** ✓ آمن (استخدام خارجي)
- **البيتادين:** ⚠ استخدم بحذر
- **Triclosan:** ✕ تجنبه (يعبر المشيمة)

Practical Advice: Hand hygiene is the pregnant nurse's **best friend**. It protects her, the baby, and the patient.

نصيحة عملية: نظافة الأيدي هي **أفضل صديق** للممرضة الحامل. بتحميها، بتحمي الطفل، وبتحمي المريض.

Source: WHO Guidelines (2009) ▪ CDC Pregnancy & IPC (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

How to Monitor & Improve Hand Hygiene / مراقبة وتحسين الالتزام

Why Monitor? "What gets measured, gets improved." Monitoring hand hygiene compliance is essential to identify gaps and improve patient safety.

ليه المراقبة؟ "اللي بيتقاس بيتحسن" مراقبة الالتزام بنظافة الأيدي ضرورية لتحديد الفجوات وتحسين سلامة المرضى.

Monitoring Methods:
- **Direct Observation** — Gold standard (WHO)
- **Electronic Monitoring** — Sensors
- **Product Usage** — Track consumption
- **Patient/Staff Surveys**
- **HAI Rates** — Indirect indicator

طرق المراقبة:
- **المراقبة المباشرة** — المعيار الذهبي
- **المراقبة الإلكترونية** — سنسورات
- **استهلاك المنتجات**
- **استطلاعات** — رأي المرضى
- **معدلات العدوى** — مؤشر غير مباشر

WHO Compliance Formula:

Compliance % = (Actions ÷ Opportunities) × 100
- Actions = HH correctly performed
- Opportunities = Any of the 5 Moments
- Target: **≥ 80%** in all units
- Report: Monthly minimum

معادلة WHO للالتزام:

الالتزام % = (المرات ÷ الفرص) × 100
- المرات = نظافة تمت بشكل صحيح
- الفرص = أي من اللحظات الخمس
- الهدف: **80%** فأكتر
- التقرير: شهرياً

⚠ Barriers to Compliance:
- Time pressure & workload
- Missing supplies
- Skin irritation
- Lack of training or feedback
- Poor role modeling by leaders

⚠ عوائق الالتزام:
- ضغط الوقت وحمل العمل
- نقص المستلزمات
- تهيج الجلد
- قلة التدريب
- القدوة السيئة من القيادات

✓ Improvement Strategies:
- Multimodal WHO approach
- Regular training + audits
- Instant feedback to staff
- Reward high compliance
- Ensure product availability
- Leadership commitment

✓ استراتيجيات التحسين:
- النهج متعدد الوسائل من WHO
- تدريب دوري + مراجعات
- تغذية راجعة فورية
- مكافأة الالتزام العالي
- ضمان توفر المنتجات
- التزام القيادة

Source: WHO Hand Hygiene Self-Assessment Framework (2010) ▪ CDC Compliance (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Real-Life Clinical Scenarios & Answers / حالات حقيقية وحلولها

CASE 1 — ICU

Scenario: A nurse in ICU cared for Patient A (MRSA+), then went to Patient B (post-op) without hand hygiene. Patient B developed MRSA infection 3 days later.

السيناريو: ممرضة في ICU اعتنت بمريض A (مصاب MRSA)، ثم راحت لمريض B (بعد عملية) بدون نظافة أيدي. مريض B أصيب بـ MRSA بعد 3 أيام.

Analysis: Missed Moment 4 (After Patient A) + Moment 1 (Before Patient B) = Cross-infection.

التحليل: نسيت اللحظة 4 (بعد A) + اللحظة 1 (قبل B) = عدوى متقاطعة.

CASE 2 — Emergency

Scenario: During a code blue, a nurse handled blood without gloves, then quickly used ABHR before helping the next patient. Is this correct?

السيناريو: أثناء إنعاش قلبي، ممرضة تعاملت مع دم بدون جوانتي، ثم استخدمت الكحول بسرعة قبل مساعدة المريض التالي. هل هذا صحيح؟

Answer: ✗ Wrong! When hands are visibly soiled with blood, use SOAP & WATER, not ABHR.

الإجابة: ✗ غلط! لما الأيدي متسخة بدم، استخدم **ماء وصابون**، مش الكحول.

CASE 3 — NICU

Scenario: A parent visits their newborn in NICU wearing a wedding ring and long fingernails. The nurse allows entry after simple hand washing. Correct?

السيناريو: والدة تزور طفلها في NICU وهي لابسة خاتم وأظافر طويلة. الممرضة سمحت لها بالدخول بعد غسيل بسيط. صح؟

Answer: ✗ Wrong! In NICU, ALL rings, long/artificial nails are strictly forbidden.

الإجابة: ✗ غلط! في NICU، كل الخواتم والأظافر الطويلة ممنوعة تماماً.

CASE 4 — C. difficile

Scenario: A nurse cared for a patient with C. difficile diarrhea and used ABHR after removing gloves. Is this adequate?

السيناريو: ممرضة اعتنت بمريض عنده إسهال C. difficile واستخدمت الكحول بعد خلع الجوانتي. هل ده كافي؟

Answer: ✗ Wrong! Alcohol does NOT kill C. difficile spores. Must use SOAP & WATER.

الإجابة: ✗ غلط! الكحول ما يقتلش جراثيم C. difficile. لازم استخدام **ماء وصابون**.

Source: WHO Case Studies (2009) ▪ CDC Clinical Scenarios (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Hand Hygiene During Emergencies / نظافة الأيدي في الحالات الطارئة

The Rule: Even in emergencies, hand hygiene is NOT optional. But you must adapt — use ABHR for speed, and full wash after the crisis is over.

القاعدة: حتى في الطوارئ، نظافة الأيدي مش اختيارية. لكن لازم تتكيف — استخدم الكحول للسرعة، والغسيل الكامل بعد انتهاء الأزمة.

Code Blue / Cardiac Arrest:
- ABHR before touching patient (10 sec)
- Full HH after removing gloves
- Between team members: quick ABHR
- Full wash after end of code

كود أزرق / سكتة قلبية:
- كحول قبل لمس المريض (10 ثواني)
- غسيل كامل بعد خلع الجوانتي
- بين أعضاء الفريق: كحول سريع
- غسيل كامل بعد نهاية الكود

Massive Bleeding / Trauma:
- Don sterile gloves immediately
- After stabilization: full soap & water
- Never use ABHR when hands soiled with blood
- Report exposure to occupational health

نزيف شديد / حادثة:
- البس جوانتي معقم فوراً
- بعد الاستقرار: ماء وصابون كامل
- لا تستخدم الكحول لو الإيدين ملطخة بالدم
- بلّغ الصحة المهنية عن التعرض

Mass Casualty Incidents:
- ABHR is the main option (fast)
- Use portable ABHR bottles
- Change gloves between patients
- Set up mobile handwashing stations
- Reinforce standard precautions

حوادث جماعية:
- الكحول هو الخيار الأساسي (سريع)
- استخدم زجاجات كحول محمولة
- غيّر الجوانتي بين المرضى
- جهّز محطات غسيل متنقلة
- عزّز الاحتياطات القياسية

Suspected Outbreak / Pandemic:
- Follow strict PPE protocol
- Extended hand hygiene (double the standard)
- Use dedicated wash sinks
- Report ALL suspected cases immediately
- Follow institution's outbreak plan

تفشي مشتبه / جائحة:
- اتبع بروتوكول PPE صارم
- نظافة أيدي مطولة (ضعف المعتاد)
- استخدم أحواض غسيل مخصصة
- بلّغ عن كل الحالات المشتبهة فوراً
- اتبع خطة المنشأة

Emergency Golden Rule: Speed matters, but skipping hand hygiene will cost more time (and lives) later. 20 seconds of ABHR can save weeks of infection treatment.

قاعدة ذهبية للطوارئ: السرعة مهمة، لكن تجاهل نظافة الأيدي سيكلفك وقت أكتر (وأرواح) بعدين. 20 ثانية كحول ممكن توفر أسابيع علاج عدوى.

Source: WHO Emergency IPC Guidelines (2020) ▪ CDC Emergency Preparedness (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Golden Insights from 6+ Years ICU Experience / خلاصات ذهبية من 6 سنين خبرة

Pearl 1: Never trust "quick hand rub." Full 20 seconds ABHR is the minimum. Count in your head.	**لؤلؤة 1:** لا تثق في "الفرك السريع". 20 ثانية كامل هو الحد الأدنى. عُد في راسك.
Pearl 2: Empty ABHR dispensers are the #1 hidden cause of missed hand hygiene. Check them at start of every shift.	**لؤلؤة 2:** موزعات الكحول الفاضية هي السبب الأول لتفويت نظافة الأيدي. افحصهم في بداية كل مناوبة.
Pearl 3: The moment you're most tempted to skip HH (fatigue, rush, distraction) is exactly when you MUST do it.	**لؤلؤة 3:** اللحظة اللي بتحس فيها إنك عايز تتخطى النظافة هي بالظبط اللحظة اللي لازم تعملها فيها.
Pearl 4: Your stethoscope is an extension of your hands. Clean it with alcohol swab between EVERY patient.	**لؤلؤة 4:** السماعة الطبية امتداد لإيدك. نظّفها بمنديل كحول بين كل مريض والتاني.
Pearl 5: Phone use in clinical areas = massive contamination. If you must use it, ABHR immediately after.	**لؤلؤة 5:** استخدام الموبايل في مناطق العمل = تلوث ضخم. لو مضطر تستخدمه، كحول فوراً بعده.
Pearl 6: Leadership sets the tone. If seniors don't do HH, juniors won't either. Be the role model.	**لؤلؤة 6:** القيادة بتحدد الثقافة. لو الكبار مش بيعملوا نظافة أيدي، الصغار مش هيعملوا. كن القدوة.
Pearl 7: A single HAI can turn a saved life into a lost one. Never underestimate hand hygiene's power.	**لؤلؤة 7:** عدوى واحدة ممكن تحوّل حياة أنقذتها لحياة خسرتها. لا تستهين بقوة نظافة الأيدي.
Pearl 8: When teaching new staff, don't just tell them "wash hands." Show them the WHY. Understanding = compliance.	**لؤلؤة 8:** لما تعلّم موظف جديد، ما تقلوش بس "اغسل إيدك" وريه **الليه**. الفهم = الالتزام.
Pearl 9: Never touch your face (nose, eyes, mouth) while working. Every touch = potential self-inoculation.	**لؤلؤة 9:** لا تلمس وشك أبداً (أنف، عين، فم) وأنت شغال. كل لمسة = تلقيح ذاتي محتمل.

Source: RN Ali Ashour's Clinical Experience (2018-2025) ▪ WHO Best Practices (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Quick Reference — Everything on One Page / كل شيء في صفحة واحدة

Durations المدة

- **Hand Wash:** 40-60 sec
- **ABHR:** 20-30 sec
- **Antiseptic:** 40-60 sec
- **Surgical:** 2-6 min

Products المنتجات

- **Alcohol:** 60-95%
- **Chlorhexidine:** 4%
- **Betadine:** 7.5%
- **Triclosan:** Antimicrobial

WHO 5 Moments اللحظات الخمس

1. Before patient / قبل المريض
2. Before aseptic / قبل معقم
3. After fluids / بعد سوائل
4. After patient / بعد المريض
5. After surroundings / بعد المحيط

11 Steps الـ 11 خطوة

Wet → Soap → Palm to palm → Back of hands → Interlace → Fingers → Thumbs → Fingertips → Rinse → Dry

⚠ ABHR DON'T متى لا الكحول

- Visibly dirty / متسخة
- C. difficile / إسهال
- Before eating / قبل الأكل
- Blood exposure / بعد دم

Compliance الالتزام

Formula:
Actions ÷ Opportunities × 100
Target: ≥ 80%
ICU/NICU: 100%

✕ NEVER Use ممنوع

- Bar soap / صابون صلب
- Shared towels / فوط مشتركة
- Artificial nails
- Rings / خواتم

Golden Rule القاعدة الذهبية

- Dirty → **Soap+Water**
- Clean → **Alcohol**
- Before gloves + After
- Dry = 1000x safer

REMEMBER: Hand hygiene is the #1 measure to prevent HAIs. Compliance saves lives!

تذكّر: نظافة الأيدي هي أول إجراء لمنع عدوى المستشفيات. الالتزام ينقذ الأرواح!

Source: WHO Quick Reference Guide (2023) • CDC Cheat Sheet.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Complete OSCE Checklist for Hand Hygiene / كاملة OSCE قائمة تقييم

OSCE Station: Hand Hygiene (5-min station)

Total: 20 points. Passing: 16/20 (80%). Score each step 0-2 (0=not done, 1=partial, 2=complete).

محطة OSCE: نظافة الأيدي (5 دقائق)

الإجمالي: 20 نقطة. النجاح: 16/20 (80%). كل خطوة 0-2.

1	Greet patient & introduce yourself.	حيّ المريض وقدّم نفسك.	/ 2
2	Remove jewelry, watch, rings.	اخلع الإكسسوارات، الساعة، الخواتم.	/ 2
3	Roll sleeves up to elbows.	شمّر الأكمام لحد الكوعين.	/ 2
4	Wet hands with warm running water.	بلل الإيدين بالماء الجاري الدافئ.	/ 2
5	Apply enough liquid soap (3-5 mL).	حط كمية صابون كافية (3-5 مل).	/ 2
6	Perform all 11 steps correctly (40-60 sec).	أدّ الـ 11 خطوة بشكل صحيح (40-60 ث).	/ 2
7	Rinse thoroughly, hands lower than elbows.	اشطف جيداً، الإيدين تحت الكوع.	/ 2
8	Dry with single-use paper towel.	جفف بفوطة استخدام واحد.	/ 2
9	Close tap using paper towel (not bare hand).	اقفل الحنفية بالفوطة (مش بإيدك).	/ 2
10	Explain the WHO 5 Moments to examiner.	اشرح للممتحن اللحظات الخمس.	/ 2

Passing Criteria:
- Total ≥ 16/20 (80%)
- Steps 4, 6, 8, 9 are **critical** — must score 2/2
- Any missed critical step = automatic fail

معايير النجاح:
- الإجمالي ≥ 16/20 (80%)
- خطوات 4، 6، 8، 9 **حرجة** — لازم 2/2
- أي خطوة حرجة ناقصة = رسوب تلقائي



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

37 — OSCE Examiner Tips نصائح من الممتحن

Insider Tips from OSCE Examiners / نصائح من الممتحنين لتجاوز المحطة

Tip 1: Speak Aloud!
Don't just do — narrate every step. "I'm now wetting my hands with warm water..." Examiners LOVE this.

نصيحة 1: تكلم بصوت عالي!
ماتعملش بس — اشرح كل خطوة بصوت عالي. "أنا دلوقتي ببلل إيدي بالمياه الدافئة.." الممتحنين بيحبوا كده.

Tip 2: Timing Awareness
Examiner has a stopwatch. Count in your head: "Palm to palm... 1,2,3,4,5..." Practice until 40-60 sec feels natural.

نصيحة 2: الوعي بالوقت
الممتحن معاه ساعة توقيت. عُد في راسك: "كف على كف... 1، 2، 3، 4، 5.." تمرن لحد ما 40-60 ث تبقى طبيعية.

Tip 3: Watch Body Language
Maintain confidence. Don't fidget or look nervous. Stand tall, work smoothly — examiner assesses your professionalism.

نصيحة 3: راقب لغة الجسد
حافظ على الثقة. متلعبش في إيدك أو تظهر توتر. قف باستقامة، اشتغل بسلاسة — الممتحن بيقيّم احترافيتك.

⚠ Tip 4: Critical Errors = Auto-Fail
- Touching tap with clean hand
- Missing thumbs entirely
- Washing less than 20 sec
- Skipping the 5 Moments question

⚠ نصيحة 4: أخطاء = رسوب تلقائي
- لمس الحنفية بإيدك النضيفة
- نسيان الإبهام تماماً
- غسيل أقل من 20 ثانية
- تخطي سؤال اللحظات الخمس

Tip 5: Common Questions
Prepare for these examiner questions:
- "Why did you dry with paper towel?"
- "What if patient has C. difficile?"
- "How long is surgical scrub?"
- "Name the 5 Moments"

نصيحة 5: أسئلة شائعة
استعد للأسئلة دي:
- "ليه جففت بفوطة ورق؟"
- "لو المريض عنده C. difficile؟"
- "قد إيه الغسيل الجراحي؟"
- "قول اللحظات الخمس"

Tip 6: Practice Makes Perfect
Practice at home with a stopwatch. Video yourself. Watch it critically. Adjust and repeat 10+ times before exam day.

نصيحة 6: التدريب أساس النجاح
تدرب في البيت بساعة توقيت. صوّر نفسك فيديو. شوفه بعين ناقدة. عدّل وكرر 10+ مرات قبل يوم الامتحان.

Source: RN Ali Ashour's Experience as Nursing OSCE Assessor ▪ NCLEX OSCE Prep (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Fun Ways to Remember Everything / طرق مرحة للحفظ

"5 MOMENTS" = PABAS

Patient — Before touching
Aseptic — Before procedure
Body fluids — After exposure
After Patient contact
Surroundings — After touching

PABAS = "اللحظات الخمس"

P قبل لمس المريض
A قبل إجراء معقم
B بعد سوائل الجسم
A بعد لمس المريض
S بعد لمس المحيط

"TWO Happy Birthdays"

Sing "Happy Birthday" song TWICE while washing = exactly 20 seconds. Perfect for teaching children!

"مرتين "Happy Birthday

غنّي أغنية Happy Birthday مرتين وأنت بتغسل = بالظبط 20 ثانية. مثالية لتعليم الأطفال!

"WASH" for 11 Steps

Wet hands
Apply soap
Scrub (all 9 sub-steps)
Hang & dry (rinse + towel)

"WASH" لـ 11 خطوة

W بلل الإيدين
A حط الصابون
S افرك (كل الـ 9 خطوات)
H اشطف وجفف

"SOAP" vs "ALCOHOL"

Soiled hands = **S**oap & water
Clean hands = **C**hlorhexidine/Alcohol
Diarrhea (C. diff) = **D**on't use alcohol

"الماء" vs "الكحول"

إيد **متسخة** = **ماء** وصابون
إيد **نضيفة** = **كحول**
إسهال (C. diff) = **ماء** وصابون فقط

"80/20 Rule"

80% = Minimum compliance target for all units
20% = Maximum time for surgical scrub if using alcohol rub

"قاعدة 80/20"

80% = الحد الأدنى للالتزام في كل الأقسام
20% = الحد الأقصى للغسيل الجراحي بالكحول

Source: WHO Educational Materials (2023) • Nursing Mnemonic Guides.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Multiple Choice Questions / أسئلة اختيار من متعدد

Q1: Minimum duration for hand washing with soap & water?

a) 10 sec b) 20 sec
c) 40-60 sec d) 2 min

✓ **Answer: c) 40-60 seconds**

س1: أقل مدة لغسل الأيدي بالماء والصابون؟

أ) 10 ث ب) 20 ث
ج) 40-60 ث د) 2 د

✓ **الإجابة: ج) 40-60 ثانية**

Q2: Which type of hand hygiene is NOT effective against C. difficile?

a) Soap & water
b) Alcohol-based rub
c) Chlorhexidine
d) Betadine

✓ **Answer: b) Alcohol — doesn't kill spores**

س2: أي نوع نظافة أيدي مش فعّال ضد C. difficile؟

أ) ماء وصابون
ب) الكحول
ج) كلورهيكسيدين
د) بيتادين

✓ **الإجابة: ب) الكحول — لا يقتل الجراثيم المُبَوَّغة**

Q3: Which is the "most forgotten" WHO Moment?

a) Moment 1 - Before patient
b) Moment 3 - After fluids
c) Moment 5 - After surroundings
d) Moment 2 - Before procedure

✓ **Answer: c) Moment 5 (Surroundings)**

س3: أي لحظة من اللحظات الخمس "الأكثر نسياناً"؟

أ) لحظة 1 - قبل المريض
ب) لحظة 3 - بعد السوائل
ج) لحظة 5 - بعد المحيط
د) لحظة 2 - قبل الإجراء

✓ **الإجابة: ج) لحظة 5 (المحيط)**

Q4: Effective alcohol concentration in ABHR?

a) 30-50%
b) 60-95%
c) 100%
d) 40-50%

✓ **Answer: b) 60-95% (100% evaporates too fast)**

س4: التركيز الفعّال للكحول في المطهرات؟

أ) 30-50%
ب) 60-95%
ج) 100%
د) 40-50%

✓ **الإجابة: ب) 60-95% (100% يتبخر بسرعة)**

Q5: Compliance target in ICU?

a) 50%
b) 60%
c) 80%
d) 100%

✓ **Answer: d) 100% (no exceptions)**

س5: نسبة الالتزام المستهدفة في ICU؟

أ) 50%
ب) 60%
ج) 80%
د) 100%

✓ **الإجابة: د) 100% (بدون استثناءات)**

Q6: Why do we dry hands with paper towel?

س6: ليه نجفف بفوطة ورقية؟

40 — True/False + Fill in the Blanks — صح أو خطأ + أكمل الفراغ

Quick True/False Assessment / تقييم سريع صح أو خطأ

1	Alcohol-based rub is effective against C. difficile spores.	الكحول فعّال ضد جراثيم C. difficile المُبَوَّغة.	FALSE
2	Wearing gloves eliminates the need for hand hygiene.	لبس الجوانتي بيغني عن نظافة الأيدي.	FALSE
3	Hand washing should last 40-60 seconds.	غسل الأيدي لازم 40-60 ثانية.	TRUE
4	Wet hands transfer more bacteria than dry hands.	الإيد الرطبة بتنقل بكتيريا أكتر من الجافة.	TRUE
5	Surgical scrub uses hands ABOVE the elbows.	الغسيل الجراحي الإيدين فوق الكوعين.	TRUE
6	Bar soap is preferred over liquid soap in hospitals.	الصابون الصلب مفضل عن السائل في المستشفيات.	FALSE
7	Artificial nails are allowed in NICU with proper HH.	الأظافر الصناعية مسموحة في NICU مع نظافة جيدة.	FALSE
8	100% alcohol is more effective than 70% alcohol.	الكحول 100% أكثر فعالية من 70%.	FALSE

✍ Fill in the Blanks:

1. WHO created _____ Moments for Hand Hygiene. **(5)**
2. Compliance formula: Actions ÷ _____ × 100. **(Opportunities)**
3. ABHR duration is _____ seconds. **(20-30)**
4. Surgical scrub uses _____% Chlorhexidine. **(4)**
5. Break the _____ of Infection. **(Chain)**

✍ أكمل الفراغ:

1. منظمة الصحة العالمية عملت _____ لحظات لنظافة الأيدي. **(5)**
2. معادلة الالتزام: الفعل ÷ _____ × 100. **(الفرص)**
3. مدة الكحول _____ ثانية. **(30-20)**
4. الغسيل الجراحي يستخدم _____% كلورهيكسيدين. **(4)**
5. اكسر _____ العدوى. **(سلسلة)**

Source: NurseHub Question Bank ▪ WHO Assessment Tools (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Quick Review Flashcards / بطاقات مراجعة ذكية

Hand Washing Duration	**ABHR Duration**
40-60 seconds 40-60 ثانية	**20-30 seconds** 20-30 ثانية
Surgical Scrub	**★ WHO 5 Moments**
2-6 minutes 2-6 دقائق	Before Patient, Before Aseptic, After Fluids, After Patient, After Surroundings
ABHR Contraindication	**ICU Compliance**
C. difficile Visibly soiled hands	**100%** required No exceptions
WHO Steps	**Alcohol %**
11 Steps ~5 sec each	**60-95%** Optimal antimicrobial
Chlorhexidine %	**Betadine %**
4% For ICU & Surgical	**7.5%** Antiseptic wash
Transient Flora	**Resident Flora**
Temporary microbes Easily removed	Permanent skin Reduced by surgical
Compliance Formula	**Body Fluid Exposure**
Actions ÷ Opportunities × 100 Target: ≥ 80%	Moment 3 Even with gloves!

Study Method: Cover the answer with your hand. Read the question. Guess. Check. Repeat 3 times before moving on.

طريقة المذاكرة: غطي الإجابة بإيدك. اقرأ السؤال. خمّن. اتحقق. كرر 3 مرات قبل الانتقال.

Source: NurseHub AI Flashcard System ▪ WHO Study Materials.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Everything You Need for Last-Minute Review / كل ما تحتاجه للمراجعة السريعة

The 10 Golden Points: Master these before any nursing exam or clinical rotation.

النقاط الذهبية العشر: أتقنهم قبل أي امتحان أو تدريب سريري.

1. Hand hygiene is the **#1 IPC intervention**.	**1.** نظافة الأيدي هي **الإجراء الأول** في مكافحة العدوى.
2. 4 types: Social, Antiseptic, Surgical, ABHR.	**2. 4 أنواع:** روتيني، صحي، جراحي، كحول.
3. WHO 5 Moments — memorize them all!	**3. اللحظات الخمس** — احفظهم كلهم!
4. 11 Steps = 40-60 seconds total.	**4. 11 خطوة** = 40-60 ثانية إجمالي.
5. ABHR: 20-30 sec, first-line choice.	**5. الكحول:** 20-30 ث، الخيار الأول.
6. Surgical Scrub: 2-6 min, hands ABOVE elbows.	**6. الجراحي:** 2-6 د، الإيدين فوق الكوع.
7. Never use ABHR with C. difficile.	**7. لا تستخدم** الكحول مع C. difficile.
8. Gloves ≠ hand hygiene.	**8. الجوانتي ≠** نظافة أيدي.
9. Wet hands = 1000x more bacteria.	**9. الإيد الرطبة** = بكتيريا 1000 ضعف.
10. Compliance Target: ≥80% (100% in ICU).	**10. هدف الالتزام:** ≥80% (100% في ICU).

Never Forget: Hand hygiene saves up to **50% of HAIs** and thousands of lives yearly. Compliance is a professional and ethical duty.

لا تنسى أبداً: نظافة الأيدي تنقذ حتى **50% من العدوى** وآلاف الأرواح سنوياً. الالتزام واجب مهني وأخلاقي.

Exam Success Tip: Read this page 3 times the night before your exam. Practice OSCE at home 5+ times. You've got this!

نصيحة نجاح الامتحان: اقرأ هذه الصفحة 3 مرات في الليلة اللي قبل امتحانك. تدرب على OSCE في البيت 5+ مرات. أنت قدها!

Source: NurseHub AI Study System ▪ WHO Educational Framework (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

45 — NCLEX/Prometric Tips نصائح الترخيص الدولي

International Licensing Exam Focus / التركيز في امتحانات الترخيص

What Do These Exams Test? NCLEX, Prometric, DHA, MOH exams test your ability to **APPLY** knowledge, not just recall it. Hand hygiene questions focus on scenarios.

إيه اللي بيمتحنوه؟ امتحانات NCLEX، Prometric، DHA، MOH بتمتحن قدرتك على **تطبيق** المعلومة، مش مجرد حفظها.

Common Question Themes:
- When to use ABHR vs soap & water
- C. difficile scenarios
- WHO 5 Moments application
- Compliance calculations
- Surgical scrub duration
- Neonatal precautions

المواضيع الشائعة:
- إمتى الكحول vs الماء والصابون
- سيناريوهات C. difficile
- تطبيق اللحظات الخمس
- حساب الالتزام
- مدة الغسيل الجراحي
- احتياطات حديثي الولادة

Strategy 1: Read the Scenario Twice
NCLEX loves detailed scenarios. Second reading catches details you missed. Look for keywords: "visibly soiled," "before procedure," "C. difficile."

استراتيجية 1: اقرأ السيناريو مرتين
NCLEX بيحب السيناريوهات المفصلة. القراءة التانية تكتشف تفاصيل نسيتها. ابحث عن كلمات: "متسخة مرئياً"، "قبل الإجراء"، "C. difficile".

Strategy 2: Eliminate Wrong Answers
- Options with "always" or "never" = usually wrong
- Options that violate WHO guidelines = wrong
- Options that skip hand hygiene = wrong

استراتيجية 2: استبعد الإجابات الخاطئة
- خيارات فيها "دائماً" أو "أبداً" = غلط غالباً
- خيارات تخالف WHO = غلط
- خيارات بتتجاهل نظافة الأيدي = غلط

⚠ Traps to Avoid:
- "Gloves are enough" → ALWAYS wrong
- "Alcohol works on C. difficile" → ALWAYS wrong
- "Bar soap is fine" → ALWAYS wrong
- "Skip HH if in a hurry" → ALWAYS wrong

⚠ فخاخ تجنبها:
- "الجوانتي كافي" ← غلط دايماً
- "الكحول يقتل C. difficile" ← غلط دايماً
- "الصابون الصلب مقبول" ← غلط دايماً
- "تخطى الغسيل لو مستعجل" ← غلط دايماً

Golden Advice: When in doubt, choose the answer that:
1. Protects the patient first
2. Uses **soap & water** for anything unclear
3. Follows WHO guidelines exactly

نصيحة ذهبية: لو مش متأكد، اختار الإجابة اللي:
1. بتحمي المريض أولاً
2. بتستخدم **ماء وصابون** في أي حالة غير واضحة
3. بتتبع WHO بالظبط

Source: NCLEX Pass Guides (2023) ▪ Prometric Study Materials ▪ DHA/MOH Sample Questions.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

? Frequently Asked Questions & Summary / الأسئلة الشائعة والملخص

? Q: Can I use ABHR instead of washing?
A: Yes, if hands are not visibly soiled. It's WHO's first-line choice.

؟ س: ممكن استخدم الكحول بدل الغسيل؟
ج: أيوه، لو الإيدين مش متسخة مرئياً. ده الخيار الأول عند WHO.

? Q: How often should I wash during shift?
A: There's no fixed number — apply the 5 Moments. In busy ICU, this can be 50-100+ times per shift.

؟ س: كام مرة أغسل في الشيفت؟
ج: مافيش رقم محدد — طبّق اللحظات الخمس. في ICU مزدحم، ممكن يوصل 50-100+ مرة.

? Q: My hands are getting dry, what should I do?
A: Use water-based moisturizer after each shift. Switch to ABHR (less drying than soap). Report to occupational health.

؟ س: إيدي بتجف، أعمل إيه؟
ج: استخدم مرطب مائي بعد كل شيفت. حوّل للكحول (أقل جفاف من الصابون). بلّغ الصحة المهنية.

KEY TAKEAWAYS — Never Forget These:

- Hand hygiene = **#1 measure** to prevent HAIs
- **4 types:** Social, Antiseptic, Surgical, ABHR
- **WHO 5 Moments** guide when to perform HH
- **40-60 sec** for soap; **20-30 sec** for alcohol
- **Always** before & after gloves
- **Never** use alcohol with C. difficile
- **Dry hands** = 1000x less transmission
- Target compliance = **≥80%**
- **Clean hands save lives**. Period.

أهم النقاط — لا تنساها أبداً:

- نظافة الأيدي = **الإجراء الأول** لمنع عدوى المستشفيات
- **4 أنواع:** روتيني، صحي، جراحي، كحول
- **اللحظات الخمس** بتحدد إمتى تعملها
- **40-60 ث** للصابون؛ **20-30 ث** للكحول
- **دائماً** قبل وبعد الجوانتي
- **أبداً** لا تستخدم الكحول مع C. difficile
- **الإيد الجافة** = نقل عدوى أقل 1000 ضعف
- هدف الالتزام = **80% فأكتر**
- **الإيدين النضيفة بتنقذ الأرواح**. خلاص.

Source: WHO FAQ Guide (2023) ▪ CDC Hand Hygiene Q&A ▪ NurseHub Community.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Continue Your Learning Journey / كمّل رحلة التعلم

Related NurseHub Articles:
- Personal Protective Equipment (PPE)
- Isolation Precautions (Contact, Droplet, Airborne)
- Sterilization & Disinfection
- Central Line Care & CLABSI Prevention
- Urinary Catheter Care & CAUTI Prevention
- Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Bundle
- Antimicrobial Stewardship

مقالات ذات صلة من NurseHub:
- معدات الحماية الشخصية (PPE)
- احتياطات العزل
- التعقيم والتطهير
- رعاية القسطرة المركزية ومنع CLABSI
- رعاية القسطرة البولية ومنع CAUTI
- حزمة منع الالتهاب الرئوي (VAP)
- الإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية

REFERENCES (APA 7 Format):

1. **World Health Organization.** (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care*. Geneva: WHO Press.

2. **Centers for Disease Control and Prevention.** (2023). *Guideline for hand hygiene in healthcare settings*. Atlanta: CDC.

3. **Pittet, D., Hugonnet, S., Harbarth, S., et al.** (2000). Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. *The Lancet, 356*(9238), 1307-1312.

4. **Boyce, J. M., & Pittet, D.** (2002). Guideline for hand hygiene in health-care settings. *MMWR Recommendations and Reports, 51*(RR-16), 1-45.

5. **Sax, H., Allegranzi, B., Uçkay, I., et al.** (2007). 'My five moments for hand hygiene'. *Journal of Hospital Infection, 67*(1), 9-21.

6. **World Health Organization.** (2023). *Save lives: Clean your hands campaign*. https://www.who.int

المراجع (تنسيق APA 7):

1. **منظمة الصحة العالمية.** (2009). *إرشادات نظافة الأيدي في الرعاية الصحية*. جنيف: مطبوعات WHO.

2. **مركز مكافحة الأمراض الأمريكي.** (2023). *دليل نظافة الأيدي في المنشآت الصحية*. أتلانتا: CDC.

3. **Pittet وآخرون.** (2000). فعالية برنامج شامل لتحسين الالتزام. *مجلة Lancet، 356*(9238)، 1307-1312.

4. **Boyce & Pittet.** (2002). دليل نظافة الأيدي. *MMWR، 51*(RR-16).

5. **Sax وآخرون.** (2007). "لحظاتي الخمس لنظافة الأيدي". *Journal of Hospital Infection، 67*(1)، 9-21.

6. **منظمة الصحة العالمية.** (2023). *أنقذ الأرواح: نظّف يديك*. https://www.who.int

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

THANK YOU!

شكراً لك

"Every time you clean your hands, you save a life.
Never underestimate this simple act."

— RN Ali Ashour, BSN

Congratulations on Completing This Guide!

مبروك على إكمال هذا الدليل!

Stay Connected with NurseHub Egypt

Website: nursehub-egypt.vercel.app

WhatsApp: 01095652098

Vodafone Cash: 01013489017

InstaPay: wekaali321

Get More Nursing Guides at NurseHub!

nursehub-egypt.vercel.app

© 2025 NurseHub Egypt — All Rights Reserved

RN, Ali Ashour, BSN ▪ ICU Specialist ▪ BLS Certified